

Monograf

MODEL FAMILY CENTER NURSING DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA TB PARU SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGOBATAN TB PARU

Mila Triana Sari
Daryanto
Hesty



Buku Monograf
MODEL *FAMILY CENTER NURSING*
DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA
TB PARU
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN
KEPATUHAN PENGOBATAN TB PARU

Ns. Mila Triana Sari, M.Kep.
Daryanto, SKP., M.Kep.
Ns. Hesty, S.Kep.,M.Kes.



Buku Monograf
Model *Family Center Nursing*
Dalam Pemberdayaan Keluarga TB Paru
Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pengobatan
Tb Paru

Ns. Mila Triana Sari, M.Kep.

Daryanto, SKP., M.Kep.

Ns. Hesty, S.Kep., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-623-89965-0-6

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal

Tiktok @maskokooo

www.optimaluntuknegeri.com

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku monograf yang berjudul Model *Family Centered Nursing* dalam Pemberdayaan Keluarga TB Paru sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kepatuhan Pengobatan TB Paru dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi penulis dalam bidang keperawatan komunitas, khususnya dalam penerapan model asuhan keperawatan yang berpusat pada keluarga dalam perawatan pasien tuberkulosis paru. Fokus utama dalam buku ini adalah pada strategi pemberdayaan keluarga sebagai pendukung utama dalam keberhasilan pengobatan TB Paru, yang menjadi salah satu tantangan besar dalam dunia kesehatan masyarakat.

Penulisan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, material, serta ilmu pengetahuan yang sangat berarti dalam proses penyusunan karya ini.

Harapan penulis, buku ini dapat memberikan manfaat bagi tenaga kesehatan, mahasiswa keperawatan, dan praktisi yang berkecimpung dalam pengelolaan kasus TB Paru. Penulis juga menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan berbasis keluarga, khususnya dalam mendukung kesembuhan pasien TB Paru melalui kepatuhan dalam menjalani pengobatan.

Mei, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA..... iv

DAFTAR ISI vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 KONSEP *FAMILY CENTERED NURSING* 6

A. Konsep Model Community as Partner..... 7

B. Penerapan *Family Centered Nursing* 8

BAB 3 KONSEP PEMBERDAYAAN 12

A. Tujuan Pemberdayaan 21

B. Proses Pemberdayaan 23

C. Prinsip Pemberdayaan Keluarga 25

D. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 26

BAB 4 KONSEP KEPATUHAN..... 28

A. Pengertian Kepatuhan..... 28

B. Aspek-Aspek Kepatuhan..... 31

C. Dimensi Kepatuhan 31

D. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi
Kepatuhan 33

E. Kriteria Kepatuhan 37

F. Pengukuran Kepatuhan 37

G. Strategi Meningkatkan Kepatuhan 38

H. Ketidakpatuhan Minum Obat..... 39

BAB 5 KONSEP TB PARU	40
A. Diagnosa TB Paru	40
B. Pengobatan Tuberkulosis	51
C. Pencegahan Tuberkulosis	53
 BAB 6 HUBUNGAN <i>FAMILY NURSE CENTER</i> DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA.....	56
A. Konsep Family Nurse Center (FNC)	56
B. Pemberdayaan Keluarga dalam <i>Family Nurse Center</i>	65
C. Peran Keluarga dalam Pengobatan TB Paru	69
D. Peran <i>Family Nurse Center</i> dalam Pengobatan TB Paru	75
E. Integrasi <i>Family Nurse Center</i> dengan Pemberdayaan Keluarga dalam TB Paru	76
 BAB 7 PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA.....	81
GLOSARIUM	87
PROFIL PENULIS.....	91



BAB 1

PENDAHULUAN

Salah satu penyakit yang sering memengaruhi kehidupan keluarga adalah tuberkulosis (TBC). Hingga saat ini, TBC masih menjadi masalah kesehatan utama baik secara nasional maupun global. Fakta ini tercermin dalam laporan global tentang TBC, yang menempatkan TBC sebagai salah satu penyebab utama kematian di dunia (WHO, 2021). Tingginya angka kematian dan jumlah kasus TBC menunjukkan bahwa masalah ini masih belum terkendali. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa pada tahun 2020, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat TBC, dengan sekitar 10 juta orang menderita TBC di seluruh dunia. Bakteri penyebab TBC dapat ditularkan melalui batuk, bersin, atau meludah, yang berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain (WHO, 2021).

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah kasus TBC tertinggi di dunia, menghadapi beban penyakit yang signifikan. Jumlah pasien TBC di Indonesia diperkirakan mencapai 845.000 orang, dengan sekitar 98.000 kematian, atau setara dengan 11 kematian per jam (Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Namun, hanya sekitar 67% dari kasus tersebut yang terdeteksi dan diobati, meninggalkan sekitar 283.000 orang yang berisiko menularkan penyakit ini kepada orang lain. Seseorang dengan TBC aktif dapat menularkan penyakit ini kepada 5–15 orang lainnya melalui kontak erat dalam waktu satu tahun, sehingga penularan dalam keluarga menjadi perhatian serius (Kaiser Family Foundation, 2021).

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan insiden TBC tertinggi di Indonesia, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara dari hasil cakupan pengobatan penderita TBC di Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2021 diperoleh jumlah kasus TB pada Tahun 2021 ada sebanyak 3.682 jiwa (Profil Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021).

Ketika seorang anggota keluarga mengalami masalah kesehatan, hal tersebut dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Penyakit yang diderita anggota keluarga dapat mengganggu komunikasi, mengubah pola aktivitas keluarga, serta memengaruhi peran dalam keluarga (Broekema et al., 2020). Selain itu, reaksi emosional seperti rasa takut, bingung, sedih, cemas, dan kesulitan menerima situasi baru umumnya muncul ketika keluarga pertama kali mengetahui bahwa salah satu anggotanya menderita penyakit kronis, termasuk TBC (Kartika et al., 2015).

TBC merupakan salah satu penyakit kronis yang berdampak pada kehidupan keluarga. TBC cenderung memiliki implikasi sosial bagi anggota keluarga, menyebabkan perasaan malu, marah, dan bersalah dalam keluarga. Sebuah studi di Nepal yang secara khusus membahas stigma dan diskriminasi terkait penyakit ini menemukan bahwa baik pasien maupun keluarganya lebih memilih mengisolasi diri dari masyarakat umum (Baral et al., 2007). Mengingat tingginya prevalensi TBC secara global maupun nasional, serta tingginya angka kematian, peran keluarga dalam memberikan perawatan dan dukungan kepada pasien TBC sangatlah penting. Merawat anggota keluarga yang terinfeksi TBC dapat berdampak positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Prabawa et al., 2018). Namun demikian, anggota keluarga yang memberikan perawatan intensif juga dapat mengalami beban emosional dan fisik, yang berdampak pada kualitas perawatan yang diberikan (Beach & Schulz, 2017). Dukungan dari perawat komunitas dapat membantu mengurangi beban perawatan pada keluarga (Van Houtven et al., 2011). Studi menunjukkan bahwa kolaborasi antara anggota keluarga dan perawat komunitas dalam memberikan perawatan di rumah sangat penting (Ris et al., 2019).

Dalam kerangka ini, keluarga memainkan peran penting dalam perawatan kesehatan, termasuk mengidentifikasi masalah, membuat keputusan, memberikan perawatan, menyesuaikan lingkungan rumah, dan memanfaatkan layanan kesehatan (Friedman et al., 2010). Memberikan

perawatan kepada keluarga dapat memberdayakan mereka untuk mengelola penyakit secara lebih efektif, dengan dampak yang lebih terkendali terhadap kehidupan keluarga. Pendekatan berbasis keluarga telah terbukti berhasil membantu keluarga beradaptasi dengan kehidupan bersama penyakit yang sebelumnya sulit dihadapi (Stones, 2020).

Pemberdayaan keluarga dapat dipandang sebagai suatu proses memandirikan klien dalam mengontrol status kesehatannya. Pemberdayaan keluarga memiliki makna bagaimana keluarga memampukan dirinya sendiri dengan difasilitasi orang lain untuk meningkatkan atau mengontrol status kesehatan keluarga dengan cara meningkatkan kesanggupan keluarga melakukan fungsi dan tugas perawatan kesehatan keluarga. Namun demikian, optimalisasi pendekatan pemberdayaan keluarga dapat terganggu dari adanya suatu model yang akan dijadikan pedoman dan rujukan saat melakukan pelayanan keperawatan. Suatu model akan berdampak positif dan baik bila dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemberi dan pengguna pelayanan kesehatan khususnya dalam hal ini adalah profesi tenaga perawat anak dan keluarga. Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan dalam family-centered nursing yang menjelaskan bahwa keluarga memiliki hak dan kewenangan untuk merawat anaknya. Maka dari itu salah satu pendekatan pelayanan dalam keperawatan adalah berpusat pada keluarga (family- centered nursing).

Pemberdayaan dan kepatuhan merupakan dua konsep penting dalam penanganan TB paru. Pemberdayaan, khususnya keluarga penderita TB, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan, memberikan perawatan, dan menjaga lingkungan yang mendukung kesehatan. Kepatuhan, di sisi lain, merujuk pada kemampuan pasien untuk mengikuti pengobatan sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan, termasuk meminum obat dengan benar, tepat waktu, dan sampai tuntas.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan keluarga dalam merawat pasien TB Paru, tenaga kesehatan, khususnya perawat komunitas, upaya menerapkan Perawatan Keperawatan Keluarga dalam konteks permasalahan TB Paru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penerapan perawatan keperawatan dalam keluarga yang menghadapi masalah terkait TBC dengan memberikan perawatan yang komprehensif dan efektif untuk mengelola kondisi kesehatan anggota keluarga yang terinfeksi TB Paru dengan menggunakan Model *Family Center Nursing*.



BAB 2

KONSEP *FAMILY CENTERED NURSING*

Keluarga merupakan unit dasar untuk perawatan individu dari anggota keluarga dan dari unit yang lebih luas, perpektif inilah yang mendasari praktik keluarga sebagai pusat keperawatan (*family-centered nursing*). Keluarga adalah unit dasar dari sebuah komunitas dan masyarakat, mempersenaskan perbedaan budaya, rasial, etnik, dan sosioekonomi.

Konsep *family-centered nursing* menjelaskan bahwa keluarga memiliki hak dan kewenangan untuk merawat anak-anaknya. Teori family-centerd nursing diungkapkan oleh Frideman (2003) yang berpendapat bahwa family-centered nursing adalah kemampuan perawat memberikan asuhan keperawatan keluarga, sehingga memandirikan anggota keluarga agar tercapai peningkatan kesehatan seluruh anggota keluarganya dan keluarga mampu mengatasi masalah kesehatan.

Mengapa keluarga menjadi sentral dalam perawatan?

1. Keluarga sebagai sumber dalam perawatan kesehatan.
2. Masalah kesehatan individu akan berpengaruh pada anggota keluarga lainnya.
3. Keluarga menjadi tempat berlangsungnya komunikasi individu sepanjang hayat, sekaligus menjadi harapan bagi anggota keluarga.
4. Penemuan kasus-kasus penyakit diawali dari keluarga
5. Anggota keluarga lebih mudah menerima suatu informasi, jika informasi tersebut didukung oleh anggota keluarga lainnya.
6. Keluarga merupakan support system bagi individu.

Asuhan Keperawatan keluarga Di Komunitas Menggunakan Model *Community as Partner* dan *Family Center Nursing*

A. Konsep Model *Community as Partner*

Community as partner merupakan model digunakan dalam mengaplikasikan ilmu keperawatan komunitas. Pada keperawatan keluarga dengan TB Paru. Model ini merupakan dasar dalam pengkajian, analisa diagnosa, perencanaan, implementasi komunitas khususnya keluarga yang terdiri dari tingkatan pencegahan primer, sekunder dan tersier serta program evaluasi.

Model *community as partner* menekankan komunitas sebagai mitra, serta menekankan pada filosofi pelayanan primer sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Model *Community as partner* digunakan

untuk mengkaji sumber-sumber yang dimiliki oleh keluarga dengan TB Paru. Model *community as partner* mempunyai tiga bagian yaitu inti komunitas, dan delapan subsistem yang mempengaruhi masyarakat atau sebaliknya yang meliputi subsistem lingkungan, pendidikan keamanan dan transportasi, politik dan pemerintahan pelayanan kesehatan dan sosial komunikasi, ekonomi dan rekreasi dan ketika persepsi masyarakat.

Rencana program kesehatan komunitas pada keluarga dengan resiko tinggi dengan anggota keluarga menderita TB Paru berdasarkan *community as partner* memfokuskan pada tingkat pencegahan primer dilakukan melalui pendidikan kesehatan tentang TB Paru, Perawatan TB Paru di rumah, Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, kepatuhan minum obat dan pencegahan penularan, sedangkan pencegahan sekunder diterapkan dengan screening deteksi dini TB Paru.

B. Penerapan *Family Centered Nursing*

Aplikasi dari teori ini adalah penerapan asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan *family-centered nursing* dapat dilakukan dengan pendekatan proses keperawatan berdasarkan Friedman model. Proses keperawatan keluarga dengan *family-centered nursing* meliputi pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi.

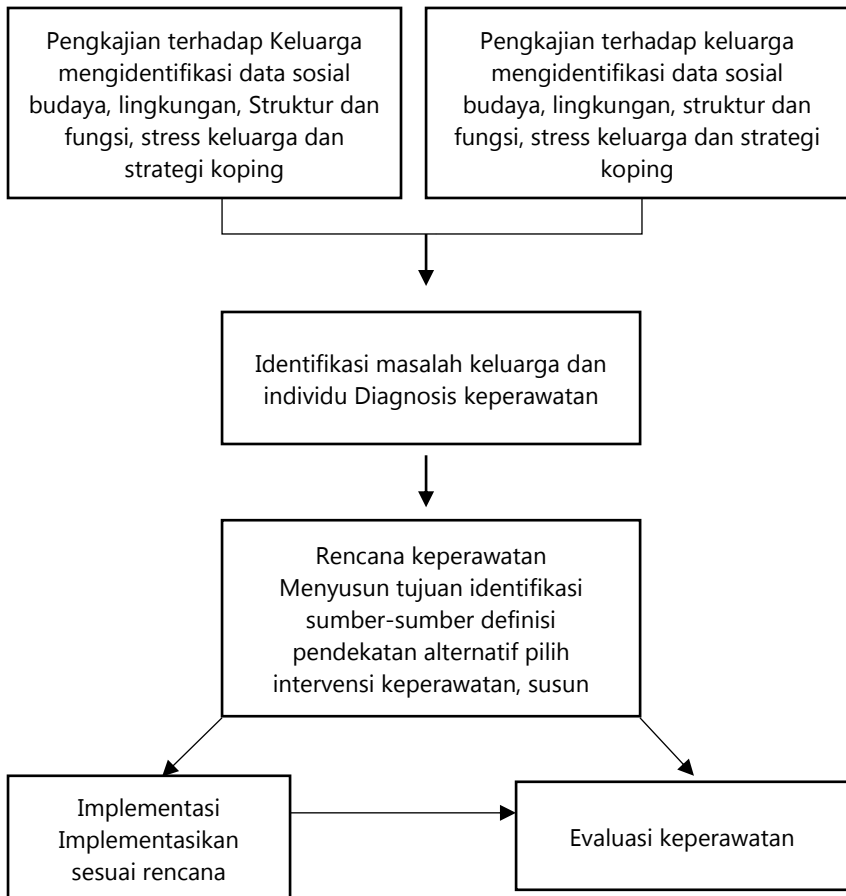
Proses keperawatan keluarga akan berbeda tergantung pada fokus perawatan. Perawat yang menkonseptualisasi sebagai unit perawatan, kemudian keluarga sebagai unit atau sistem adalah fokus yang diinginkan. Perawat keluarga dalam kenyataannya harus menstimulasi individu dan keluarga dalam sistem keluarga.

Hal ini berarti perawat dalam menerapkan asuhan keperawatan keluarga harus menerapkan dua strategi yaitu perawatan individu dan keluarga serta Keluarga sebagai sistemnya. Melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan akan menjadi lebih kompleks dalam penerapan pada asuhan keperawatan keluarga dengan TB Paru. Penerapan asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan *family centered nursing* salah satunya menggunakan Model *Family Centered Nursing* berdasarkan Friedman Model, sebagai berikut:

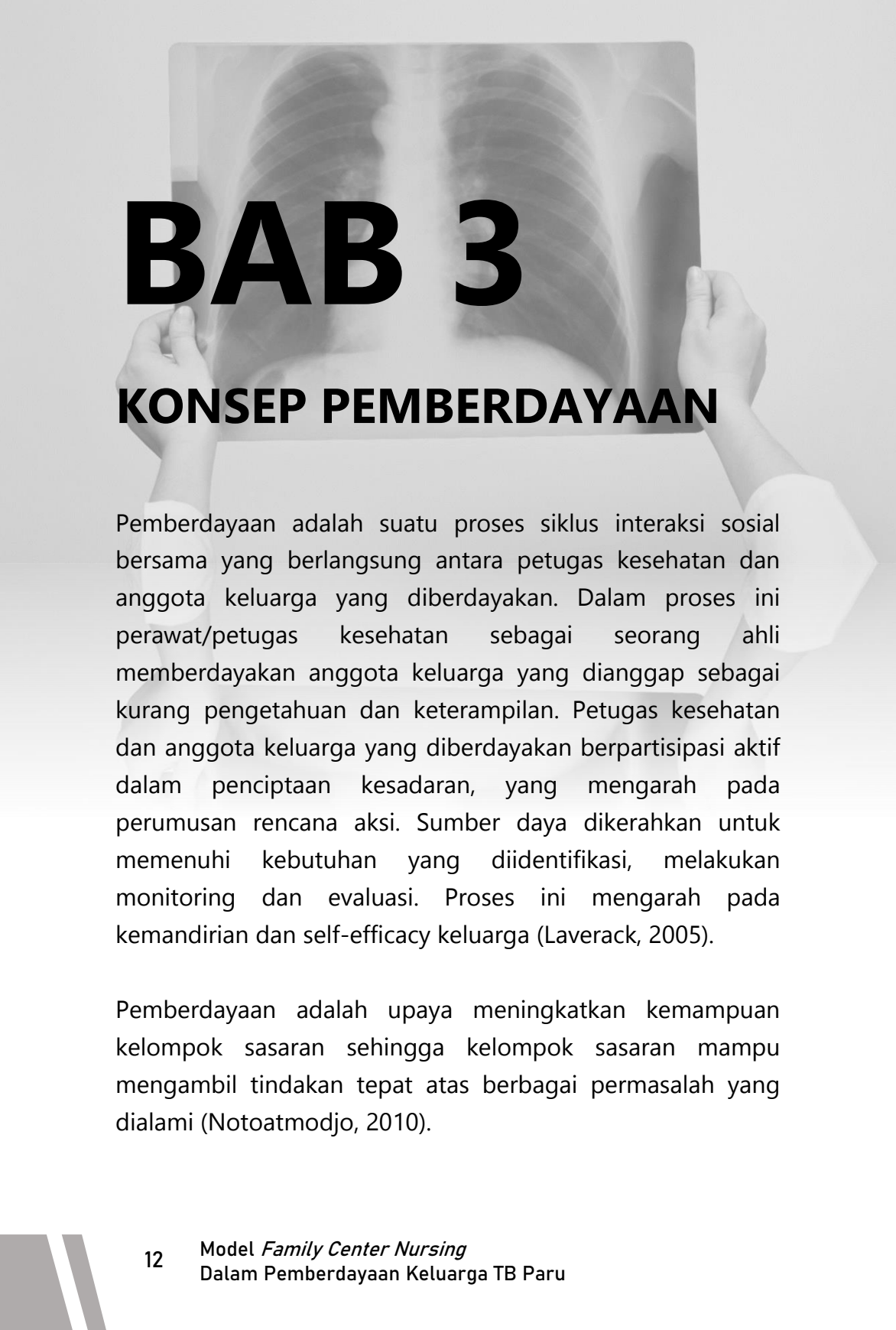
1. Pengkajian: tahapan dimana seorang perawat mendapat informasi secara terus-menerus terhadap keluarga yang menjadi kliennya
2. Diagnosis keperawatan: data yang telah didapatkan sebelumnya dilakukan analisis, sehingga dapat dirumuskan diagnosis keperawatan keluarga bisa berupa diagnosis aktual, risiko, dan potensial.
3. Perencanaan: Penetapan tujuan dan rencana tindakan keperawatan dilakukan bersama-sama dengan keluarga, karena keluarga bertanggung jawab dalam mengatur kehidupannya, dan tugas perawat membantu

- menyediakan informasi yang relevan untuk memudahkan keluarga dalam mengambil keputusan.
4. Implementasi: Perawat dapat menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat, memberi kemampuan dan kepercayaan diri kepada keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit, serta perawat dapat membantu keluarga dalam membuat lingkungan menjadi sehat, dan memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
 5. Evaluasi: evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kognitif, afektif dan psikomotor keluarga. Evaluasi perlu dilakukan pada setiap tindakan yang telah diberikan sebelumnya, sehingga dapat ditentukan apakah tindakan tersebut perlu dilakukan lagi atau tidak atau dapat ditambahkan tindakan lain.

Proses Keperawatan Keluarga



Tabel 2.1 Alur Proses Keperawatan



BAB 3

KONSEP PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan adalah suatu proses siklus interaksi sosial bersama yang berlangsung antara petugas kesehatan dan anggota keluarga yang diberdayakan. Dalam proses ini perawat/petugas kesehatan sebagai seorang ahli memberdayakan anggota keluarga yang dianggap sebagai kurang pengetahuan dan keterampilan. Petugas kesehatan dan anggota keluarga yang diberdayakan berpartisipasi aktif dalam penciptaan kesadaran, yang mengarah pada perumusan rencana aksi. Sumber daya dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi, melakukan monitoring dan evaluasi. Proses ini mengarah pada kemandirian dan self-efficacy keluarga (Laverack, 2005).

Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan kelompok sasaran sehingga kelompok sasaran mampu mengambil tindakan tepat atas berbagai permasalahan yang dialami (Notoatmodjo, 2010).

Pemberdayaan keluarga adalah suatu proses atau upaya untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan keluarga dalam memelihara dan meningkatkan status kesehatan (Notoatmodjo, 2012). Pentingnya pemberdayaan keluarga membantu mereka menjadi lebih aktif dalam merawat penderita TB, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan menurunkan risiko penularan.

Pemberdayaan keluarga dapat dilakukan melalui berbagai bentuk edukasi, mulai dari penyuluhan mengenai pentingnya kepatuhan pengobatan, penanganan efek samping obat, hingga cara-cara mencegah penularan penyakit di lingkungan keluarga. Kemenkes RI (2020) menyarankan pentingnya program-program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam merawat pasien TB. Penyuluhan yang diberikan oleh tenaga medis atau petugas kesehatan komunitas dapat meningkatkan pemahaman keluarga tentang pentingnya mendukung pengobatan TB hingga tuntas. Sutrisna dan Hidayati (2021) juga mengungkapkan bahwa pemberdayaan keluarga melalui pelatihan praktis, seperti cara merawat pasien TB dengan baik, dapat mengurangi kekhawatiran keluarga dan meningkatkan kualitas dukungan yang diberikan. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah pendekatan *Directly Observed Treatment, Shortcourse* (DOTS), di mana keluarga turut serta mengawasi jalannya pengobatan dan memastikan pasien mengonsumsi obat sesuai jadwal.

Keluarga adalah bagian penting dalam proses kesembuhan pasien. Dukungan keluarga sangat diperlukan oleh penderita TB dalam memotivasi mereka selama pengobatan. Keluarga harus selalu membimbing dan mengarahkannya agar dapat minum obat dengan benar dan teratur, keluarga perlu menyediakan dana untuk biaya pengobatan. Bukan hanya itu saja, keluarga harus memberikan pasien perasaan nyaman, merasa dicintai meskipun saat mengalami suatu masalah, membimbing pasien melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan pasien dan memotivasi klien untuk sembuh (Yahya, 2021).

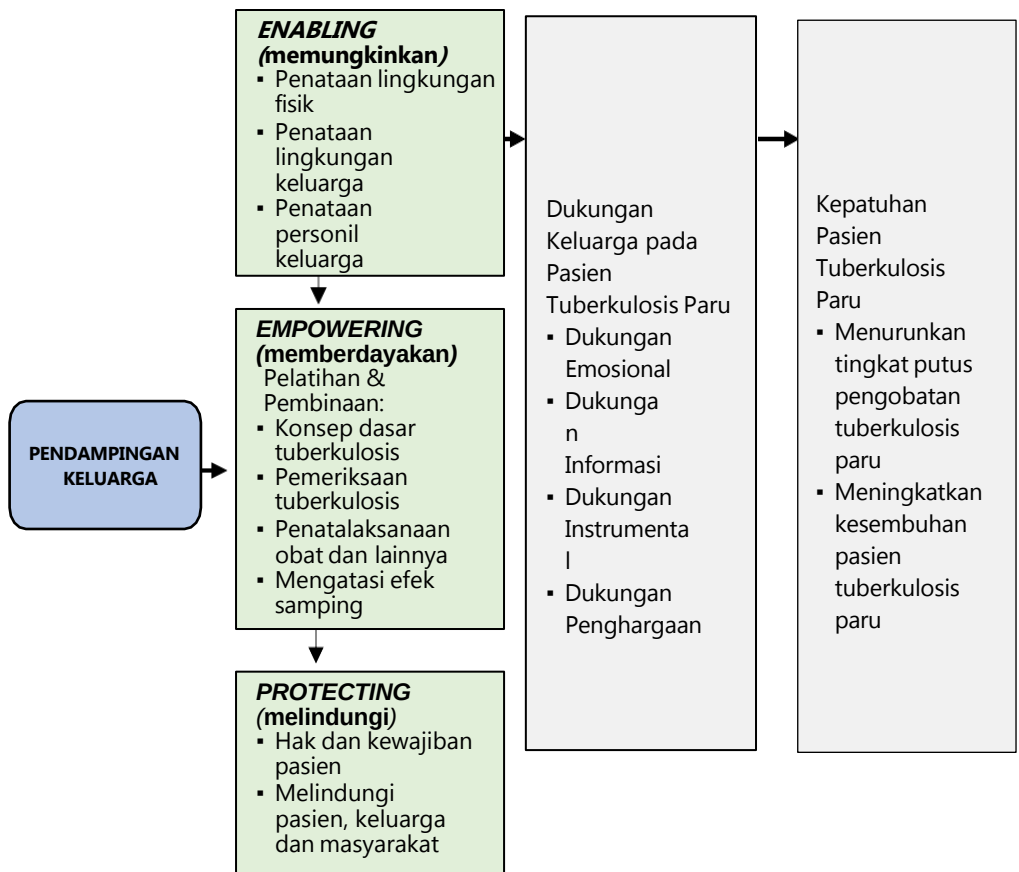
Menurut Sari et al (2020), dukungan keluarga merupakan faktor penting dalam memotivasi penderita tuberkulosis paru, untuk berupaya aktif dalam mengobati penyakitnya dan mencegah penularan tuberkulosis paru.

Selain dukungan keluarga, penderita TB Paru membutuhkan setidaknya satu orang yang bertugas mengingatkannya untuk meminum obat, disebut sebagai Pengawas Minum Obat (PMO) (Kemenkes RI, 2017). Penderita TB harus mematuhi seorang PMO untuk mencegah terjadinya kegagalan pengobatan. PMO sangat penting bagi pengobatan TB yang sedang dijalani pasien. Peran PMO dalam proses pengobatan TB adalah membawa pasien TB ke tenaga kesehatan, mengingatkan pasien dalam meminum obat, memberi obat untuk diminum setiap malam, memotivasi pasien serta

mengantarkan pasien dalam melakukan pengobatan di Puskesmas (Kepmenkes RI, 2019).

Faktor individual seperti keyakinan, sikap, atau motivasi untuk sembuh juga berperan penting. Motivasi yang kuat dan keyakinan pasien bahwa mereka dapat sembuh melalui pengobatan yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan dalam mengonsumsi obat. Efikasi diri, atau kepercayaan pada kemampuan diri untuk menguasai situasi, juga terkait erat dengan kepatuhan pasien tuberkulosis paru dalam mengonsumsi obat anti-tuberkulosis (OAT), sebagaimana dibuktikan oleh penelitian Sukartini (2019).

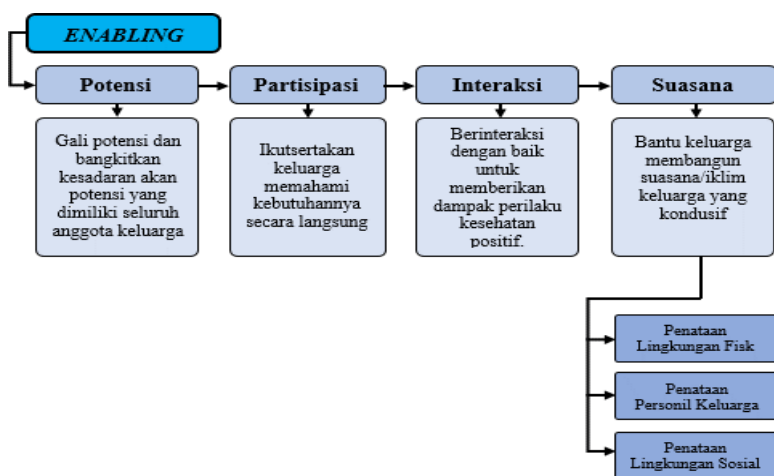
Dapat dilihat pada gambar 3.1 dukungan keluarga yang riil dilakukan pada penelitian ini dalam lingkup dukungan instrumental (menyediakan materi berupa uang, barang, tenaga, dan pelayanan), dukungan informasional (memberikan informasi berupa saran atau umpan balik tentang situasi dan kondisi individu), dukungan emosional (memberikan perhatian, perasaan nyaman, kasih sayang, empati dan dicintai oleh keluarga), serta dukungan penghargaan (menolong individu untuk memahami kejadian/penyakit lebih baik dan penyebabnya serta strategi koping menghadapinya).



Gambar 3.1 Pendampingan Keluarga Pada Pasien Tuberkulosis Paru

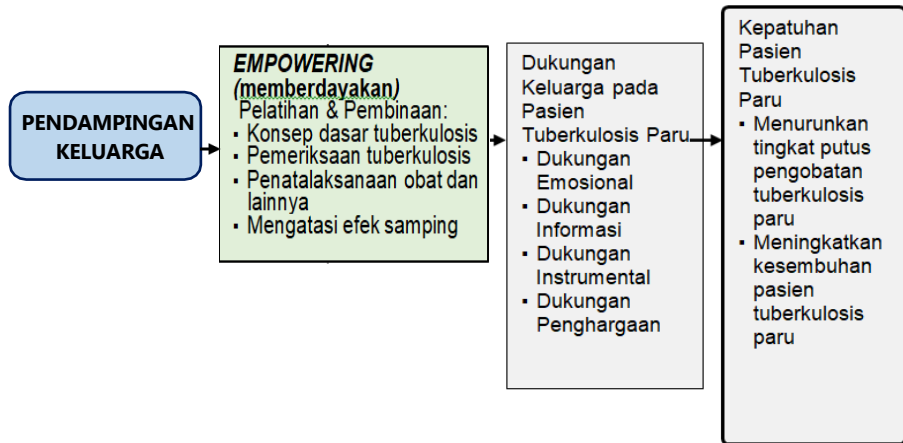
Pada Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa proses pemberdayaan keluarga melalui pendampingan, meliputi Enabling merupakan upaya menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan William yang mengatakan bahwa, "*'enabling' consists of a series of related managerial processes which, when used effectively*

and in concert, help others to do what they need to do". Dapat dilihat pada Gambar 3.2, strategi pendampingan keluarga terkait aspek enabling. Kegiatan nyata dari enabling ini dapat dilakukan melalui penancangan program-program pemberdayaan dengan melibatkan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam setiap program pemberdayaan. Keterlibatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat ini merupakan langkah awal membangkitkan kemandirian masyarakat dengan mengikutsertakan mereka memahami kebutuhannya secara langsung. Penciptaan iklim yang kondusif yang dilakukan dengan memadukan pasien dengan para anggota keluarga dan suasana keluarga yang kondusif dapat memengaruhi motivasi dan tanggung jawab pasien dan keluarganya sehingga akan mendorong keluarga dan pasien terlibat dalam penanganan masalah kesehatan. Interaksi keluarga sangat diperlukan karena akan memberikan dampak dan hasil positif terhadap perilaku kesehatan.



Gambar 3.2 Strategi Pendampingan Keluarga terkait Aspek Enabling

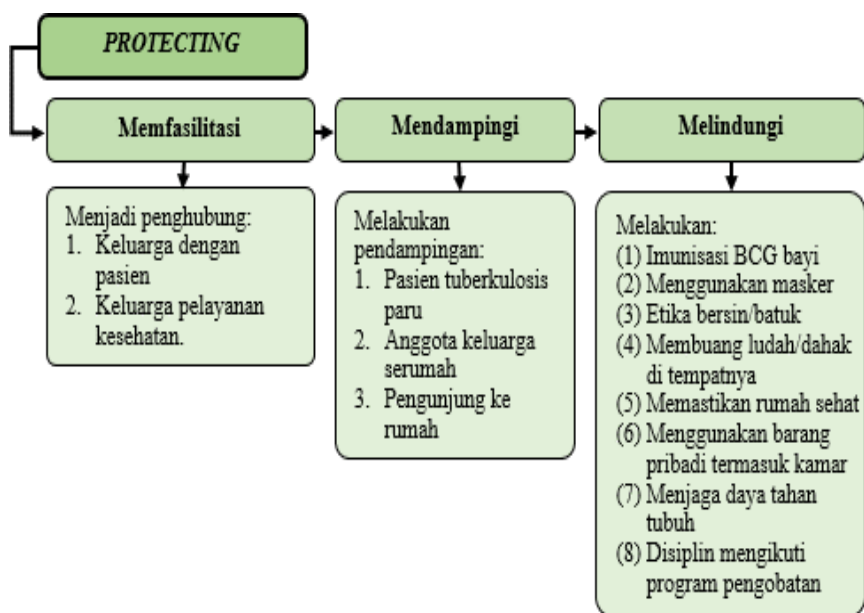
Pemberdayaan (*empowering*) adalah upaya untuk memperkuat potensi individu, keluarga, dan/atau masyarakat melalui tindakan konkret, seperti penyediaan berbagai input dan pembukaan peluang yang memungkinkan mereka untuk berdaya. Strategi pendampingan keluarga terkait aspek enabling dapat dilihat pada Gambar 3.2. Dalam upaya pemberdayaan ini, peningkatan tingkat pendidikan/pengetahuan, derajat kesehatan, serta akses ke sumber daya (termasuk fasilitas layanan kesehatan) bagi lapisan masyarakat paling bawah yang kurang berdaya merupakan langkah-langkah yang paling fundamental. Oleh karena itu diperlukan program khusus, seperti pelatihan dan pengawasan berkelanjutan, karena program-program yang umum kemungkinan tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Pelatihan merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan dalam waktu relatif singkat dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada teori. Pelatihan adalah salah satu bentuk edukasi dengan prinsip-prinsip pembelajaran, dimana pihak yang diberikan pelatihan (keluarga) harus memiliki motivasi untuk belajar, harus mempunyai kemampuan untuk belajar, proses pembelajaran harus dapat dipaksakan atau diperkuat, dan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat dipraktikkan sesuai kebutuhan.



Gambar 3.3 Model Pemberdayaan Keluarga Aspek Empowering

Protecting merupakan upaya melindungi dan membela kepentingan individu, keluarga, dan/atau masyarakat. Peran utama keluarga sebagai pendamping berpengaruh pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pasien, keluarga dituntut mampu menjadi jembatan penghubung antara pasien dan pelayanan kesehatan. Secara operasional, arah dan cakupan dalam upaya pemberdayaan keluarga pada pasien tuberkulosis, yaitu mendorong untuk tumbuh dan menciptakan, mendayagunakan sumber daya yang telah tersedia dengan lebih baik, dan menciptakan ruang dan peluang untuk kesembuhan pasien. Untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kesehatan diri dan keluarganya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pembudayaan dan pengalaman.

Strategi pendampingan keluarga terkait aspek *protecting* dapat dilihat pada gambar 3.4 di bawah ini.



Gambar 3.4 Strategi Pendampingan Keluarga terkait Aspek *Protecting*

Kegiatan riil yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan kader dalam pendampingan kepada keluarga pasien tuberkulosis dari aspek *enabling* yaitu menggali potensi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki seluruh anggota keluarga, mengikutsertakan keluarga memahami kebutuhannya, berinteraksi dengan baik untuk memberikan dampak perilaku kesehatan positif dan membantu keluarga membangun suasana/iklim keluarga yang kondusif. Kegiatan petugas kesehatan dan kader dalam pendampingan keluarga dari aspek *empowering* yaitu melakukan edukasi, mendemonstrasikan tindakan,

dan mengawasi pelaksanaan kepatuhan konsumsi obat, sedangkan kegiatan kader dalam pendampingan keluarga dari aspek *protecting* yaitu menjadi penghubung dengan pelayanan kesehatan, melakukan pendampingan pada pasien, anggota keluarga dan pengunjung rumah, serta melakukan perlindungan untuk seluruh anggota keluarga.

A. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah membantu keluarga memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan hambatan sosial dalam pengambilan tindakan (Notoatmodjo, 2012). Adapun tujuan pemberdayaan keluarga dalam bidang kesehatan adalah:

1. Menumbuhkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran kesehatan bagi anggota keluarga. Pengetahuan dan kesadaran tentang cara-cara memelihara dan meningkatkan kesehatan adalah awal dari pemberdayaan kesehatan. Kemampuan ini diperoleh melalui proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan proses yang dimulai dengan adanya alih pengetahuan dari sumber belajar kepada subjek belajar. Oleh karena itu, kemampuan keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan diperoleh melalui proses belajar dari petugas kesehatan.
2. Kemauan atau kehendak untuk melakukan tindakan kesehatan, yaitu merupakan kecenderungan untuk

melakukan suatu tindakan. Kemauan kemungkinan dapat dilanjutkan ketindakan, tetapi mungkin juga tidak, atau terhenti pada kemauan saja. Berlanjut atau tidaknya kemauan menjadi tindakan sangat tergantung pada beberapa faktor. Faktor utama yang mendukung berlanjutnya kemauan menjadi tindakan adalah sarana dan prasana untuk mendukung tindakan.

3. Keluarga mampu untuk melakukan tindakan perilaku sehat. Menurut Lawrence Green (1980) dalam (Notoatmodjo, 2007), untuk dapat terwujudnya perilaku hidup sehat ditunjang oleh faktor:
 - a. Faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap keluarga terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan keluarga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut di masyarakat. tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi.
 - b. Faktor pemungkin (*enabling factors*), faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk perilaku sehat keluarga memerlukan sarana dan prasarana pendukung, misalnya Rumah sakit, Puskesmas, Pustu, dokter praktik, klinik perawatan.
 - c. Faktor penguat (*reinforcing factors*), faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat (toma), tokoh agama (toga), sikap dan perilaku petugas kesehatan termasuk perawat, undang-undang, peraturan-peraturan baik dari pusat maupun dari daerah yang terkait dengan kesehatan.

B. Proses Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan mengemuka sejak dicanangkannya Strategi Global WHO tahun 1984, yang ditindak lanjuti dengan rencana aksi dalam piagam Ottawa (1986). Dalam deklarasi tersebut dinyatakan tentang perlunya mendorong terciptanya:

1. kebijakan berwawasan kesehatan,
2. lingkungan yang mendukung
3. reorientasi dalam pelayanan kesehatan,
4. keterampilan individu dan
5. gerakan masyarakat (Notoatmodjo, 2010).

Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan kemampuannya, diantaranya melalui pendayagunaan potensi keluarga dan lingkungan.

Ada tiga syarat dalam proses pemberdayaan keluarga/masyarakat, yaitu:

1. Kesadaran, kejelasan serta pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan.
2. Pemahaman yang baik tentang keinginan berbagai pihak (termasuk keluarga) tentang hal-hal apa, dimana, dan siapa yang akan diberdayakan.
3. Adanya kemauan dan keterampilan kelompok sasaran untuk menempuh proses pemberdayaan.

Kemampuan keluarga dalam bidang kesehatan sesungguhnya mempunyai pengertian yang sangat luas. Keluarga dikatakan mampu atau mandiri dibidang kesehatan apabila:

1. Mampu mengenali masalah kesehatan dan faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan, terutama di lingkungan keluarga. Agar keluarga mampu mengenali masalah kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, keluarga harus mempunyai pengetahuan kesehatan yang baik (*heath literacy*).
2. Mampu mengatasi masalah kesehatan mereka sendiri secara mandiri. Keluarga mandiri adalah keluarga yang mampu menggali potensi-potensi keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan.
3. Mampu memelihara dan melindungi seluruh anggota keluarga dari ancaman- ancaman kesehatan, dengan pengetahuan keluarga yang tinggi tentang kesehatan keluarga mampu memelihara dan melindunginya dari segala bentuk ancaman kesehatan. Oleh karena itu, keluarga dapat melakukan tindakan antisipasi masalah kesehatan dengan upaya pencegahan.
4. Mampu meningkatkan kesehatan seluruh anggota keluarga. Tujuan akhir dari pemberdayaan keluarga adalah keluarga yang mandiri atau berdaya dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan anggota keluarganya. Pemberdayaan keluarga merupakan proses, sedangkan kemandirian keluarga merupakan hasilnya.

Oleh karena itu kemandirian keluarga dapat diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan tindakan untuk pemecahan masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada di dalam keluarga tanpa bantuan dari pihak luar.

C. Prinsip Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan keluarga adalah proses memampukan keluarga dari, oleh, dan untuk keluarga itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki (Notoatmodjo, 2012).

Prinsip-prinsip pemberdayaan keluarga dibidang kesehatan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan potensi keluarga

Potensi adalah suatu kekuatan atau kemampuan yang masih terpendam, Setiap anggota keluarga mempunyai potensi yang berbeda. Potensi itu meliputi sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, sumber daya alam disekitar keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Peran perawat adalah memampukan keluarga mengenal potensi mereka sendiri. Perawat membimbing keluarga untuk mengembangkan potensinya berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

2. Mengembangkan kerja sama

Berbagai potensi keluarga dikelola secara bersama untuk kepentingan semua anggota keluarga. Peran perawat adalah memotivasi dan memfasilitasi agar terjadi kerjasama yang harmonis dalam upaya pemberdayaan kesehatan keluarga.

3. Menggali kontribusi keluarga

Menggali dan mengembangkan potensi anggota keluarga dalam bentuk tenaga, pemikiran, ide-ide baru dan sebagainya. Perawat membantu menggali kontribusi semua anggota keluarga.

4. Menjalin kemitraan

Keluarga yang mandiri merupakan perwujudan dari kemitraan diantara anggota keluarga dengan petugas kesehatan (dokter, perawat, ahli gizi). Peran perawat adalah memotivasi dan memfasilitasi keluarga untuk menjalin kemitraan dengan petugas kesehatan yang lain.

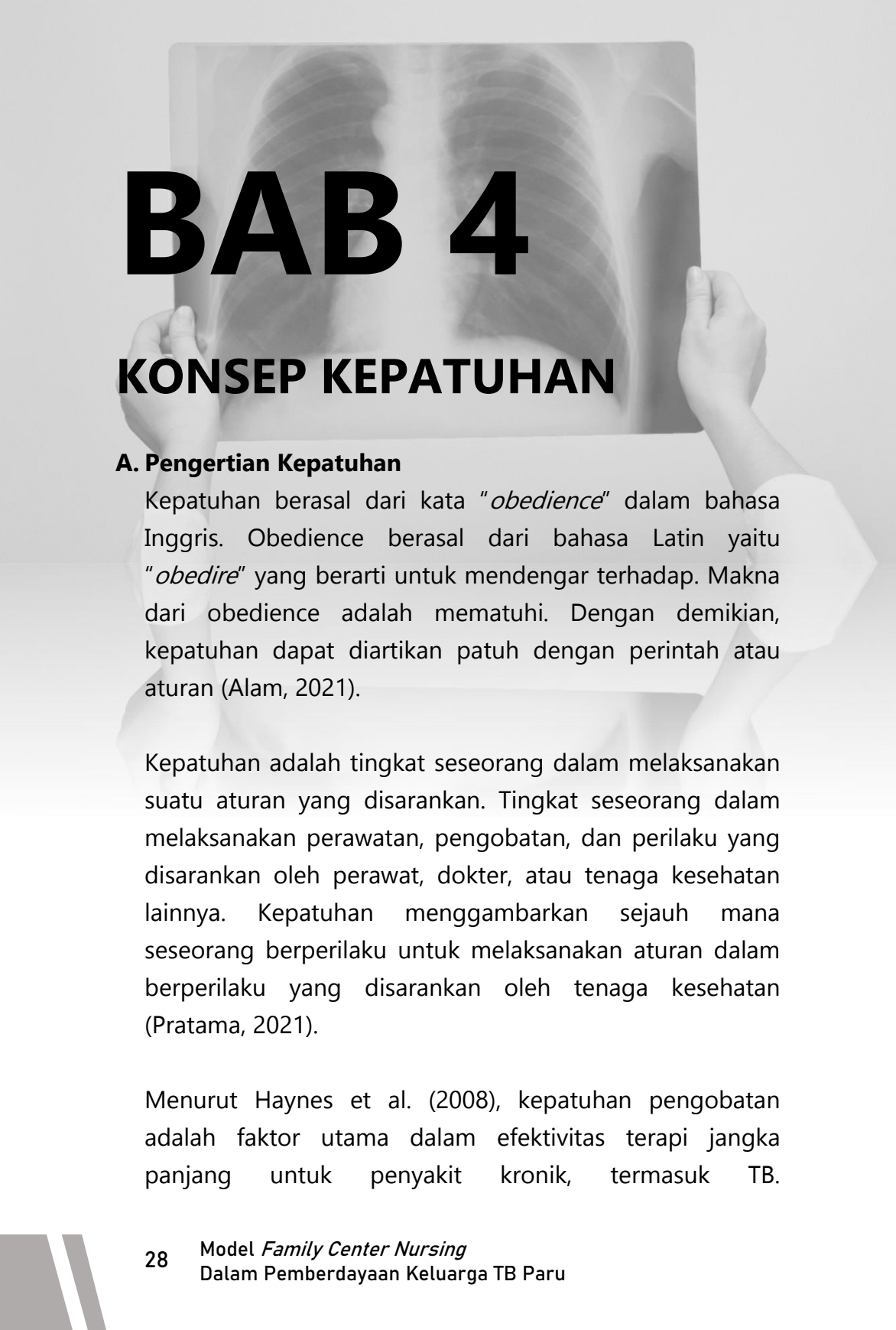
D. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Hubley (2002) dalam (Notoatmodjo, 2010) mengatakan bahwa pemberdayaan kesehatan (*health empowerment*), sadar kesehatan (*health literacy*) dan promosi kesehatan (*health promotion*) diletakkan dalam kerangka pendekatan yang komprehensif. Pemberdayaan didiskusikan dalam kerangka bagaimana mengembangkan kemampuan penduduk untuk menolong dirinya sendiri (*self-efficacy*) dari teori belajar sosial. Pemberdayaan masyarakat biasanya dilakukan dengan pendekatan pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat biasanya berisi bagaimana masyarakat mengembangkan kemampuan serta bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Health literacy adalah kondisi tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan. *Health literacy* juga bermakna bahwa masyarakat harus memahami tentang berbagai jenis penyakit, termasuk bagaimana berjangkitnya, bagaimana penularannya serta bagaimana pengobatannya. Selanjutnya setelah memahami, maka nantinya masyarakat bisa mengambil keputusan dengan benar tentang tindakan yang harus dilakukan. Berikutnya anggota Masyarakat mampu mengkomunikasikan isu-isu kesehatan kepada masyarakat lain (Notoatmodjo, 2010).



Gambar 3.5 Strategi Pemberdayaan Keluarga



BAB 4

KONSEP KEPATUHAN

A. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata "*obedience*" dalam bahasa Inggris. Obedience berasal dari bahasa Latin yaitu "*obedire*" yang berarti untuk mendengar terhadap. Makna dari obedience adalah mematuhi. Dengan demikian, kepatuhan dapat diartikan patuh dengan perintah atau aturan (Alam, 2021).

Kepatuhan adalah tingkat seseorang dalam melaksanakan suatu aturan yang disarankan. Tingkat seseorang dalam melaksanakan perawatan, pengobatan, dan perilaku yang disarankan oleh perawat, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya. Kepatuhan menggambarkan sejauh mana seseorang berperilaku untuk melaksanakan aturan dalam berperilaku yang disarankan oleh tenaga kesehatan (Pratama, 2021).

Menurut Haynes et al. (2008), kepatuhan pengobatan adalah faktor utama dalam efektivitas terapi jangka panjang untuk penyakit kronik, termasuk TB.

Ketidakpatuhan dapat menyebabkan kegagalan terapi, kekambuhan, dan perkembangan TB resisten obat.

Kepatuhan adalah sejauh mana perilaku individu sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh petugas kesehatan. Kepatuhan sebagai suatu proses yang dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Niven (2012), kepatuhan pasien dalam pengobatan dipengaruhi oleh individu atau pasien sendiri, dukungan dari keluarga, dukungan sosial juga dukungan dan karakteristik dari (pendidikan) petugas kesehatan. Menurut Kemenkes RI (2018), kepatuhan pasien TB juga dinilai dari sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh professional kesehatan. Faktor pendukung kepatuhan pasien adalah sikap atau motivasi individu untuk sembuh, keyakinan, dukungan keluarga, dukungan sosial dan dukungan petugas kesehatan.

Pengobatan TB paru memerlukan waktu yang panjang, biasanya enam bulan, dan memerlukan konsumsi obat secara teratur. Menurut *World Health Organization* (WHO) (2022), kegagalan pengobatan TB yang disebabkan oleh ketidakpatuhan pasien dapat menyebabkan perkembangan *Multi-Drug Resistant Tuberculosis* (MDR-TB) yang lebih sulit diobati dan lebih berbahaya. WHO melaporkan bahwa 10% dari kasus TB di Indonesia adalah resistensi obat, yang membutuhkan pengobatan lebih lama dan lebih mahal. Penyelesaian pengobatan TB paru tidak hanya bergantung pada ketersediaan obat dan

fasilitas kesehatan, tetapi juga pada faktor non-medik, seperti dukungan sosial, yang salah satunya berasal dari keluarga. Sutrisna dan Hidayati (2021) menemukan bahwa ketidakpatuhan terhadap pengobatan sering kali disebabkan oleh kurangnya motivasi dan dukungan psikososial dari keluarga. Keluarga yang memberikan dukungan emosional, seperti motivasi untuk tetap mengonsumsi obat, sangat berperan dalam keberhasilan pengobatan.

Kepatuhan atau "*observance*", "*adherence*" dan "*concordance*" adalah keadaan yang menggambarkan perilaku pasien dalam menelan obat dengan benar sesuai dosis, frekuensi dan waktu. Pengamatan kontekstual dalam psikologi mengacu pada situasi dimana perilaku seseorang sesuai dengan tindakan yang disarankan oleh petugas kesehatan atau informasi yang diperoleh dari sumber informasi lain dalam bentuk pamflet atau melalui media kampanye [31]. Kepatuhan sangat penting bagi pasien dengan penyakit menular dan kronis termasuk tuberkulosis paru. Perawatan dengan obat tuberkulosis berlangsung cukup lama (6-8 bulan), sehingga pasien sering mengalami kejenuhan dan kelalaian dalam penatalaksanaan perawatan tuberkulosis.

B. Aspek-Aspek Kepatuhan

Menurut Sarbani dalam Pratama (2021) persoalan kepatuhan dalam realitasnya ditentukan oleh tiga aspek, yaitu:

1. Pemegang Otoritas Status yang tinggi dari figur yang memiliki otoritas memberikan pengaruh penting terhadap perilaku kepatuhan pada masyarakat.
2. Kondisi yang terjadi Terbatasnya peluang untuk tidak patuh dan meningkatnya situasi yang menuntut kepatuhan.
3. Orang yang mematuhi Kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan karena ia mengetahui bahwa hal itu benar dan penting untuk dilakukan.

C. Dimensi Kepatuhan

Seseorang dapat dikatakan patuh kepada perintah orang lain atau ketentuan yang berlaku, apabila seseorang tersebut memiliki tiga dimensi kepatuhan yang terkait dengan sikap dan tingkah laku patuh. Berikut adalah dimensi-dimensi kepatuhan menurut Blass dalam Malikah (2017), meliputi:

1. Mempercayai (*belief*) Kepercayaan terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan yang meliputi percaya pada prinsip peraturan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.
2. Menerima (*accept*) Menerima dengan sepenuh hati perintah atau permintaan yang diajukan oleh orang lain

dengan adanya sikap terbuka dan rasa nyaman terhadap ketentuan yang berlaku.

3. Melakukan (*act*) Jika mempercayai dan menerima adalah merupakan sikap yang ada dalam kepatuhan, melakukan adalah suatu bentuk tingkah laku atau tindakan dari kepatuhan tersebut. Dengan melakukan sesuatu yang diperintahkan atau menjalankan suatu aturan dengan baik secara sadar dan peduli pada adanya pelanggaran, maka individu tersebut bisa dikatakan telah memenuhi salah satu dimensi kepatuhan. Seseorang dikatakan patuh jika norma-norma atau nilai-nilai dari suatu peraturan atau ketentuan diwujudkan dalam perbuatan, bila norma atau nilai itu dilaksanakannya maka dapat dikatakan bahwa ia patuh.

Dimensi kepatuhan menurut Basaza et al (2020), meliputi:

1. Kepatuhan farmakologis, yaitu minum obat sesuai dosis dan waktu yang ditentukan.
2. Kepatuhan terhadap jadwal kunjungan, yaitu mengikuti kontrol dan pemeriksaan lanjutan.
3. Kepatuhan perilaku, yaitu mengikuti anjuran untuk tidak merokok, menjaga pola makan, dan menghindari penyebaran infeksi.

Menurut Niven (2008), kepatuhan mencakup:

1. Kepatuhan terhadap regimen pengobatan: Mengikuti dosis, jadwal, dan durasi pengobatan yang telah ditentukan.

2. Kepatuhan terhadap kontrol rutin: Menghadiri kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai jadwal.
3. Kepatuhan terhadap perilaku hidup sehat: Menghindari faktor risiko seperti merokok dan konsumsi alkohol.

Menurut (Parluangan, 2021) adapun faktor yang mendukung kepatuhan minum obat yaitu:

1. Dukungan keluarga sebagai faktor pendorong dan berperan sebagai support system utama dan kunci keberhasilan pengobatan tuberkulosis dengan cara menghimbau penderita untuk menjalani pengobatan dan menjadi pengawas obat.
2. Faktor penting dalam kepatuhan adalah adanya dukungan social, yang berupa dukungan emosional dari teman, dan orang-orang sekitarnya serta para tim medis.

D. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Menurut Afriant & Rahmiati dalam Pratiwi (2021), faktor yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu adalah

1. Usia

Usia berhubungan dengan tingkat kepatuhan, meskipun terkadang usia bukan menjadi penyebab ketidakpatuhan namun semakin tua usia pasien maka akan semakin menurun daya ingat, pendengaran, dan penglihatan, sehingga pasien lansia menjadi tidak patuh.

2. Jenis Kelamin

Perempuan memiliki sifat penuh kasih sayang, merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang di sekitarnya, serta lembut. Sementara laki-laki cenderung memiliki sifat agresif, senang berpetualang, kasar, suka kekeluasaan dan lebih berani mengambil risiko. Dalam konteks ini risiko yang ada salah satunya yaitu risiko tertular Covid-19. Sehingga adanya perbedaan sifat ini dapat menyebabkan perempuan cenderung lebih takut untuk melanggar peraturan.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan mempengaruhi tinggi rendahnya pengetahuan seseorang. Sehingga pendidikan memang memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku. Dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan akan membentuk pengetahuan seseorang yang kemudian akan meningkatkan perilaku patuh terhadap 5M pencegahan Covid-19.

4. Pekerjaan

Dapat dikatakan bahwa, selama bekerja responden akan cenderung mentaati protokol kesehatan di lingkungan kerja. Setiap lingkungan kerja/kantor telah dihimbau oleh pemerintah agar menerapkan kebijakan selalu melakukan protokol kesehatan dalam segala kegiatan ekonomi di lingkungan kerja yang harus ditaati oleh seluruh pekerja/ karyawannya

5. Status Pernikahan

Seseorang yang hidup bersama dengan pasangannya akan memiliki kecenderungan akan selalu taat dan

patuh pada penerapan protokol kesehatan. Hal ini disebabkan mereka tidak ingin terkena paparan penyakit dan menularkannya kepada pasangannya. Mereka menjaga diri dan pasangannya dengan tetap terus menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupannya.

6. Motivasi

Motivasi merupakan salah satu faktor yang mendasari seseorang dalam berperilaku menggunakan alat proteksi diri. Setiap peningkatan motivasi akan dapat meningkatkan perilaku penggunaan alat proteksi diri dasar. Motivasi juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap suatu permasalahan. Motivasi dapat berasal dari diri individu (internal) seperti harga diri, harapan, tanggung jawab, pendidikan serta berasal dari lingkungan luar (eksternal) seperti hubungan interpersonal, keamanan dan keselamatan kerja, dan pelatihan

7. Pengetahuan

Tingkat pengetahuan yang tinggi akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan dan mengambil keputusan terhadap sesuatu yang sedang dihadapi, peningkatan pengetahuan masyarakat terkait sebuah [enyakit dapat mendorong masyarakat untuk patuh dalam mengikuti segala protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

8. Dukungan Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan gaya hidup sehat yang sangat

mendasar. Lingkungan keluarga yang mendukung berpeluang untuk mempengaruhi kepatuhan dalam berperilaku hidup sehat. Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang membentuk perilaku-perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mencapai perilaku masyarakat yang sehat harus dimulai dari keluarga.

Menurut Surati et al (2023), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat yaitu:

1. Faktor komunikasi, yang mempengaruhi Tingkat kepatuhan pasien terdapat kurangnya informasi dan pengawasan, ketidakpuasan emosional antara pasien dan petugas kesehatan, dan ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan.
2. Faktor personal meliputi pengetahuan, kepercayaan, dan sikap menjalani pengobatan.
3. Faktor pengetahuan semakin baik pengetahuan pasien TB paru terkait penyakitnya dan semakin banyak pengetahuan yang dimiliki PMO tentang penyakit tuberkulosis paru, semakin baik kepatuhan pasien dalam berobat.
4. Faktor pengobatan sangat mempengaruhi kepatuhan terkait dengan dosis obat yang diminum perhari, frekuensi obat dan lama pengobatan.

E. Kriteria Kepatuhan

Menurut Depkes RI dalam Kogoya (2019) kriteria kepatuhan seseorang dapat dibagi menjadi:

1. Patuh Suatu tindakan yang taat baik terhadap perintah ataupun aturan dan semua aturan maupun perintah tersebut dilakukan dengan benar.
2. Kurang patuh Suatu tindakan yang melaksanakan perintah ataupun aturan dan hanya sebagian aturan maupun perintah yang dilakukan dengan benar namun tidak sempurna.
3. Tidak patuh Suatu tindakan yang mengabaikan aturan dan tidak melaksanakan perintah dengan benar.

F. Pengukuran Kepatuhan

Pengukuran kepatuhan dapat dilakukan menggunakan kuesioner, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur indikator-indikator yang telah dipilih. Indikator tersebut sangat diperlukan sebagai ukuran tidak langsung mengenai standar dan masalah yang diukur melalui sejumlah tolak ukur untuk kriteria kepatuhan yang digunakan. Indikator merupakan suatu variabel (karakteristik) terukur yang dapat digunakan untuk menentukan kriteria kepatuhan, disamping itu indikator juga memiliki karakteristik yang sama dengan standar, misalnya karakteristik itu harus jelas, mudah diterapkan, sesuai dengan kenyataan dan juga dapat diukur (Utami, 2017).

G. Strategi Meningkatkan Kepatuhan

Strategi pendekatan yang berbasis keluarga, seperti Model *Family Centered Nursing*, terbukti mampu meningkatkan kepatuhan pasien TB (Yulianti et al., 2022). Strategi-strategi utama mencakup:

1. Edukasi Kesehatan: Memberikan pemahaman tentang pentingnya pengobatan yang tuntas.
2. Pelibatan Keluarga: Keluarga berperan sebagai pengingat, pendamping, dan motivator selama terapi.
3. Pemantauan Berbasis Masyarakat (DOTS): Supervisi langsung terhadap konsumsi obat (WHO, 2021).
4. Penguatan komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan (Gebreweld & Kifle, 2015).

Ada beberapa cara untuk meningkatkan kepatuhan menurut (Yunus et al., 2023) yaitu:

1. Memberi informasi kepada penderita tentang pentingnya kepatuhan untuk keberhasilan dalam pengobatan.
2. Mengingatkan penderita tentang pentingnya melakukan semua upaya yang diperlukan untuk keberhasilan dalam pengobatan baik dari telepon maupun alat komunikasi lainnya.
3. Menunjukkan kepada penderita obat yang sebenarnya yaitu dengan membuka kemasan atau vial dan sebagainya.
4. Memberikan keyakinan kepada penderita keefektifan obat.

5. Memberi tahu kepada penderita risiko ketidakpatuhan minum obat.
6. Dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat, dapat membantu penderita dalam mengingatkan untuk minum obat demi keberhasilan pengobatan.

H. Ketidakpatuhan Minum Obat

Menurut M. Sholelkhudin (2014) ketidakpatuhan minum obat merupakan suatu sikap pasien yang tidak disiplin dalam menjalani pengobatan. Menurut (Surati et al., 2023) ketidakpatuhan penderita dalam berobat jangka panjang secara rutin memperburuk kondisi kesehatan, menyebabkan kekambuhan dan kegagalan dan menimbulkan resistensi kuman (MDR), penularan ke orang lain, dan tingginya angka kematian. Ketidakpatuhan dalam minum obat dilihat dari dosis obat yang tidak sesuai, termasuk waktu dan jangka waktu yang tidak teratur.

Adapun jenis-jenis ketidakpatuhan yakni:

1. Ketidakpatuhan yang disengaja (*intentional non compliance*) disebabkan oleh biaya pengobatan yang rendah, sikap tidak peduli penderita dan penderita tidak percaya pada obat tuberkulosis.
2. Ketidakpatuhan yang tidak disengaja (*unintentional non compliance*) disebabkan karena pasien lupa minum obatnya, karena intruksi minum obat serta kesalahan dalam membaca dosis obat (Rini Palupi et al., 2023).



BAB 5

KONSEP TB PARU

A. Diagnosa TB Paru

Tuberculosis (TB) adalah penyakit yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberculosis bisa menyerang bagian paru-paru dan dapat menyerang semua bagian tubuh. Tuberculosis adalah penyakit menular langsung, sebagian besar kuman TB menyerang paru-paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Tuberculosis adalah penyakit infeksius kronik dan berulang biasanya mengenai organ paru yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*.

Bakteri tersebut masuk melalui saluran pernafasan dan saluran pencernaan dan luka terbuka pada kulit. Biasanya paling banyak melalui inhalasi droplet yang berasal dari si penderita. Bakteri masuk dan terkumpul di dalam paru-paru akan berkembang baik terutama pada orang dengan daya tahan tubuh yang rendah dan menyebar melalui pembuluh darah atau kelenjar getah bening. Oleh sebab itu infeksi TBC dapat menginfeksi hampir seluruh organ tubuh seperti paru-paru, saluran pencernaan, tulang, otak,

ginjal, kelenjar getah bening, dan lainlain, namun organ tubuh yang paling sering terkena yaitu paru-paru.

Tuberculosis (TB) dapat menyebar menyebar dengan cara yang sama dengan flu, tetapi penularannya tidak mudah. Infeksi TB biasanya menyebar antar anggota keluarga yang tinggal serumah. Seseorang bisa terinfeksi saat duduk disamping penderita di dalam bus atau kereta api. Selain itu, tidak semua orang yang terkena TB bisa menularkannya. TB disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Kuman ini berbentuk batang, memiliki dinding lemak yang tebal, tumbuh lambat, tahan terhadap asam dan alcohol, sehingga sering disebut basil tahan asam (BTA). Bakteri ini memasuki tubuh manusia terutama melalui paru-paru, namun dapat juga lewat kulit, saluran kemih, dan saluran makanan. Gejala yang ditimbulkan penyakit tuberkulosis yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Batuk yang dialami dapat disertai dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam lebih dari satu bulan.

Kuman tuberkulosis menular melalui udara, dalam dahak TB terdapat banyak sekali kuman TB. Ketika seorang penderita TB batuk atau bersin, ia akan menyebarkan 3.000 kuman ke udara. Kuman tersebut ada dalam percikan dahak, yang disebut dengan droplet nuclei atau percik renik (percik halus). Percikan dahak yang amat kecil ini

melayang-layang di udara dan mampu menembus dan mampu bersarang dalam paru-paru orang disekitarnya. Penularan ini bisa terjadi dimana saja termasuk perumahan yang bersih sekalipun (St. Carolus, 2016). Bagi orang yang memiliki kekebalan baik, kuman TB yang ada ditubuhnya tidak aktif atau berada dalam keadaan tidur (dormant). Dengan kondisi demikian, orang tersebut mengidap infeksi TB laten sehingga tidak ditemukan gejala apapun. Penderita TB laten juga tidak dapat menularkan kuman TB kepada orang lain. Namun perlu diingat, jika daya tahan tubuh penderita TB laten menurun, kuman TB akan menjadi aktif (St. Carolus, 2016).

Gejala utama pasien TB paru adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan (Kemenkes RI, 2015). Gejala-gejala tersebut diatas dapat dijumpai pula pada penyakit paru selain tb, seperti bronkiektasis, bronkitis kronis, asma, kanker paru, dan lain-lain. Mengingat prevalensi TB di Indonesia saat ini masih tinggi, maka setiap orang yang datang ke UPK dengan gejala tersebut diatas, dianggap sebagai seorang tersangka (suspek) pasien TB, dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung (Kemenkes RI, 2015).

Tuberculosis (TB) merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian teratas dan penyebab utama dari satu agen infeksi. Pada 2019, diperkirakan 10 juta orang terserang TB di seluruh dunia. 5,6 juta laki-laki, 3,2 juta perempuan dan 1,2 juta anak. TB hadir di semua negara dan kelompok umur. Secara keseluruhan 90% penderita TB adalah orang dewasa (≥ 15 tahun), 9% orang hidup dengan HIV (72% di Afrika) dan dua per tiga lainnya tersebar di beberapa negara yaitu India 27%, Tiongkok 9%, Indonesia 8%, Filipina 6%, Nigeria 4%, Bangladesh 4%, Afrika Selatan 3%. Presentase TBC paru semua tipe pada orang berjenis kelamin laki-laki lebih besar daripada orang berjenis kelamin perempuan dikarenakan laki-laki kurang memperhatikan pemeliharaan kesehatan diri sendiri serta laki-laki sering kontak dengan faktor risiko dibandingkan dengan perempuan.

Kondisi Indonesia menurut laporan WHO tahun 2018, Indonesia mendapatkan peringkat ke 3 dengan menyumbang 8% dari penderita TB di seluruh dunia. Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah penderita TB terbanyak di dunia setelah India dan China. Jumlah pasien TB di Indonesia adalah sekitar 5,8% dari total jumlah pasien TB dunia. Di Indonesia, diperkirakan setiap tahun terdapat 528.000 kasus TB baru dengan kematian sekitar 91.000 orang. Oleh karena itu kerugian ekonomi akibat TB juga cukup besar. Prevalensi TB pada pria 3 kali lebih tinggi dibandingkan pada wanita. Survei ini menemukan bahwa dari seluruh partisipan pria yang

merokok sebanyak 68,5% dan hanya 3,7% partisipan wanita yang merokok. Klasifikasi tuberkulosis dibagi menjadi; yang pertama tuberkulosis Paru BTA (+), basil tahan asam (BTA) merupakan bakteri yang menjadi salah satu indikator dalam penentuan penyakit Tuberkulosis. Pada TB paru BTA (+) menandakan bahwa dalam sputum penderita terdapat bakteri yang dapat menginfeksi orang lain. Sehingga TB jenis ini menjadi sumber penyebaran TBC. Yang kedua tuberkulosis Paru BTA (-), pada pemeriksaan sputum SPS (Sewaktu-PagiSewaktu), hasil menunjukkan tidak ada bakteri di dalam sputum dan dalam pemeriksaan rontgen dada TB aktif. Namun menurut bukan berarti penderita tidak dapat menginfeksi orang lain. TB paru BTA (-) juga dapat menginfeksi orang lain dengan resiko lebih kecil dibandingkan Tb paru BTA (+). Komplikasi yang terjadi pada penyakit TB paru yaitu, nyeri tulang belakang. Nyeri punggung dan kekakuan adalah komplikasi tuberkulosis yang umum, kerusakan sendi. Atritis tuberkulosis biasanya menyerang pinggul dan lutut, Infeksi pada meningen (meningitis). Hal tersebut dapat menyebabkan sakit kepala yang berlangsung lama atau intermiten yang terjadi selama berminggu-minggu, masalah hati atau ginjal. Hati dan ginjal memiliki fungsi membantu menyaring limbah dan kotoran dari aliran darah. Apabila terkena tuberkulosis maka hati dan ginjal akan terganggu. Gangguan jantung, hal tersebut bisa jarang terjadi, tuberkulosis dapat menginfeksi jaringan yang mengelilingi jantung.

Efusi pleura merupakan akumulasi cairan yang berlebihan di rongga pleura yang disebabkan karena meningkatnya produksi atau berkurangnya absorpsi cairan. Efusi pleura merupakan manifestasi dari banyak penyakit, mulai dari penyakit paru sampai inflamasi sistemik atau keganasan. Di negara berkembang, Tuberkulosis (TB) merupakan penyebab utama efusi pleura. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Khan et al di Qatar dan Yovi di Pekanbaru yang menyatakan penyebab efusi pleura terbanyak adalah TB paru yaitu sebesar 32,5% dan 46,3%.

Efusi pleura merupakan akumulasi cairan patologis dalam ruang pleura yang masih menjadi penyebab utama distress pernapasan di seluruh dunia. Efusi pleura nonmaligna merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik yang berasal dari pleura, paru-paru, maupun ekstrapulmoner. Penyebab efusi pleura nonmaligna yang paling umum adalah gagal jantung kongestif (*congestive heart failure – CHF*) dan pneumonia. Adanya gejalagejala penyakit penyebab seperti demam, menggigil, dan nyeri dada pleuritis (pneumonia), panas tinggi (kokus), subfebril (tuberkulosis), banyak keringat, batuk, banyak riak, Deviasi trachea menjauhi tempat yang sakit dapat terjadi jika terjadi penumpukan cairan pleural yang signifikan.

Tuberkulosis paru dapat sembuh bila pengobatan dilakukan dengan tekun dan teratur, oleh karena semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Banggai telah

menggunakan DOTS (*Directory Observe Treatment Shortcourse*). DOTS atau pengawasan langsung menelan obat jangka pendek adalah suatu cara pengawasan tuberkulosis paru dimana setiap pasien tuberkulosis paru yang ditemukan harus diawasi menelan obatnya agar menelan obat secara teratur selama 6 bulan. Kegiatan ini meliputi upaya penemuan penderita dengan pemeriksaan dahak di sarana pelayanan kesehatan yang ditindaklanjuti dengan paket pengobatan. Dalam penanganan program, semua penderita TB yang ditemukan ditindak lanjuti dengan paket-paket pengobatan intensif. Melalui paket pengobatan yang diminum secara teratur dan lengkap, diharapkan penderita akan dapat disembuhkan dari penyakit TB yang dideritanya. Namun demikian dalam proses selanjutnya tidak tertutup kemungkinan terjadi kegagalan pengobatan akibat dari paket pengobatan yang tidak terselesaikan atau drop out (DO), terjadi resistensi obat atau kegagalan dalam penegakan diagnosis di akhir pengobatan.

Menghirup *Mycobacterium Tuberculosis* menyebabkan salah satu dari empat kemungkinan hasil, yakni pembersihan organisme, infeksi laten, permulaan penyakit aktif (penyakit primer), penyakit aktif bertahun-tahun kemudian (reaktivasi penyakit). Setelah terhirup, droplet infeksius tetesan menular menetap diseluruh saluran udara. Sebagian besar bakteri terjebak dibagian atas saluran nafas dimana sel epitel mengeluarkan lender. Lender yang dihasilkan menangkap zat asing dan silia

dipermukaan sel terus-menerus menggerakkan lender dan partikelnya yang terangkap untuk dibuang. System ini memberi tubuh pertahanan fisik awal yang mencegah infeksi tuberculosis.

Klasifikasi tuberculosis dibagi menjadi; yang pertama tuberculosis Paru BTA (+), basil tahan asam (BTA) merupakan bakteri yang menjadi salah satu indikator dalam penentuan penyakit Tuberculosis. Pada TB paru BTA (+) menandakan bahwa dalam sputum penderita terdapat bakteri yang dapat menginfeksi orang lain. Sehingga TB jenis ini menjadi sumber penyebaran TBC. Yang kedua tuberculosis Paru BTA (-), pada pemeriksaan sputum SPS (Sewaktu-PagiSewaktu), hasil menunjukkan tidak ada bakteri di dalam sputum dan dalam pemeriksaan rontgen dada TB aktif. Namun menurut bukan berarti penderita tidak dapat menginfeksi orang lain. TB paru BTA (-) juga dapat menginfeksi orang lain dengan resiko lebih kecil dibandingkan Tb paru BTA (+). Tuberculosis Ekstra Paru dibagi berdasarkan tingkat keparahannya. TB Ekstra Paru Ringan misalnya, TB tulang (kecuali tulang belakang), sendi, kelenjar limfe dan kelenjar adrenal dan TB Ekstra Paru Berat misalnya: TB usus, TB saluran kencing, TB tulang belakang dan alat kelamin.

Pemeriksaan penunjang yang umum digunakan adalah Kultur sputum, Ziehl Neelsen (Acid-fast Stain applied to smear of body fluid) Skin test (PPD, Mantoux, Tine, Vollmer Patch), Foto rontgen dada (chest xray), Histologi atau kultur

jaringan (termasuk kubah lambung, urine dan CSF, serta biopsy kulit), Needle biopsy of lung tissue, Elektrolit, ABGs, Bronkografi, Pemeriksaan darah dan Tes fungsi paru.

Diagnosis TB dapat ditegakkan dari gejala klinis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan penunjang yang lain.

Gejala klinis TB paru terdiri dari gejala respiratorik berupa:

- (a) batuk ≥ 2 minggu,
- (b) batuk disertai darah,
- (c) nyeri dada, dan
- (d) sesak napas.

Sedangkan gejala sistemik terdiri dari;

- (a) demam,
- (b) keringat malam,
- (c) malaise,
- (d) anoreksia, dan
- (e) penurunan berat badan.

Menurut Fitriani (2020), diagnosis TBC antara lain:

1. Diagnosis TB Paru

- a. Semua suspek TB diperiksa 3 spesimen dahak dalam waktu 2 hari, yaitu Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS).
- b. Diagnosis TB Paru pada orang dewasa ditegakkan dengan ditemukannya kuman TB (BTA). Pada program TB nasional, penemuan BTA melalui pemeriksaan dahak mikroskopis merupakan diagnosis utama. Pemeriksaan lain seperti foto toraks, biakan dan uji kepekaan dapat digunakan

sebagai penunjang diagnosis sepanjang sesuai dengan indikasinya.

- c. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya berdasarkan pemeriksaan foto toraks saja. Foto toraks tidak selalu memberikan gambaran yang khas pada TB paru, sehingga sering terjadi overdiagnosis.
 - d. Gambaran kelainan radiologik Paru tidak selalu menunjukkan aktifitas penyakit.
 - e. Untuk lebih jelasnya lihat alur prosedur diagnostik untuk suspek TB paru.
2. Diagnosis TB Ekstra Paru
- a. Gejala dan keluhan tergantung organ yang terkena, misalnya kaku kuduk pada Meningitis TB, nyeri dada pada TB pleura (Pleuritis), pembesaran kelenjar limfe superfisialis pada limfadenitis TB dan deformitas tulang belakang (gibbus) pada spondilitis TB dan lainlainnya.
 - b. Diagnosis pasti sering sulit ditegakkan sedangkan diagnosis kerja dapat ditegakkan berdasarkan gejala klinis TB yang kuat (presumtif) dengan menyingkirkan kemungkinan penyakit lain. Ketepatan diagnosis tergantung pada metode pengambilan bahan pemeriksaan dan ketersediaan alat-alat diagnostik, misalnya uji mikrobiologi, patologi anatomi, serologi, foto toraks dan lain-lain.

Penegakan diagnosis penyakit ini membutuhkan ketrampilan dan sarana yang tidak sederhana dan memerlukan pendekatan multidisiplin kedokteran. Penyakit ini membutuhkan kerja sama yang erat dan

terpadu antara ahli paru dengan ahli radiologi diagnostik, ahli patologi anatomi, ahli radiologi terapi dan ahli bedah toraks, ahli rehabilitasi medik dan ahli-ahli lainnya.

Efusi pleura merupakan penimbunan cairan dalam rongga pleura, akibat jenis cairan yang transudat, eksudat, atau darah yang berlebihan pada rongga pleura. Adanya timbunan cairan mengakibatkan perasaan sakit karena gesekan, setelah cairan cukup banyak rasa sakit hilang. Bila cairan banyak, penderita akan sesak napas. Pada anak masalah pernapasan adalah hal yang paling sering dikeluhkan. Apabila dihubungkan dengan penyebabnya berupa pneumonia maka gejala yang muncul adalah batuk, demam, sesak napas, menggigil. Apabila penyebabnya bukan pneumonia, maka gejala pada anak mungkin tidak ditemukan sampai efusi yang timbul telah mencukupi untuk menimbulkan gejala sesak napas atau kesulitan bernapas. Di Amerika Serikat, setiap tahunnya terjadi 1,5 juta kasus efusi pleura. Sementara pada populasi umum secara internasional diperkirakan setiap 1 juta orang, 3000 orang terdiagnosis efusi pleura. Di negara-negara berat, efusi pleura terutama disebabkan oleh gagal jantung kongestif, sirosis hati, keganasan, dan pneumonia bakteri. Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, lazim diakibatkan oleh infeksi tuberkulosis.

Beberapa penyakit dapat menyebabkan terjadinya efusi pleura, antara lain infeksi seperti tuberkulosis, pneumonia, dan abses, atau penyebab non infeksi seperti karsinoma

paru, karsinoma pleura, gagal hati, gagal ginjal dan emboli paru. Di negara negara maju, efusi pleura terutama disebabkan oleh gagal jantung kongestif, sirosis hati, keganasan, dan pneumonia bakteri sementara di negara yang sedang berkembang, lazim diakibatkan oleh infeksi tuberkulosis dan keganasan. Untuk keadaan yang dapat disebabkan efusi pleura antara lain penyakit infeksi, sistemik, keganasan, obat-obatan, trauma, dan setelah tindakan operasi. Dengan berbagai keluhan utama penderita seperti sesak napas, batuk tidak produktif, dan lainnya. Pada penderita efusi pleura keluhan semakin meningkat saat aktivitas, hal ini tergantung dari tingkatan.

B. Pengobatan Tuberkulosis

Pengobatan TB terdiri atas 2 tahap:

1. Tahap awal (intensif) selama 2 bulan atau 56 hari dan lanjutan selama 4 bulan.

Obat yang diminum merupakan kombinasi dari isoniazid, rifampicin, pyrazinamide dan etambutol. Di tahap awal, pengidap TB dengan yang menjalani pengobatan rutin akan tidak lagi menular dalam kurun waktu dua minggu. Dua bulan sejak pengobatan awal, dahak yang mengandung kuman TB hidup (BTA positif) akan berbalik menjadi negatif. BTA negatif tetap dapat memiliki risiko penularan, tapi jauh lebih kecil dibandingkan BTA positif. Pada pengidap TB yang mengalami resistensi, peluang balik dari BTA positif ke negatif hanya sekitar 50% dan angka kesembuhan hanya sebesar 65% (Willy, 2019).

2. Tahap lanjutan, jumlah dan dosis obat yang diberikan akan berkurang, tapi durasi pengobatannya berlangsung lebih lama. Tahap ini penting untuk menyingkirkan kuman yang resisten sehingga tidak terjadi kekambuhan atau resistensi. Menurut Kemenkes RI (2011), pengobatan TB hingga sembuh membutuhkan waktu sekitar 6 bulan hingga 2 tahun dengan melakukan beberapa terapi yakni:

a. Pengobatan Kombinasi

Ini merupakan penggunaan berbagai macam obat untuk memastikan bakteri tidak menjadi kebal terhadap antibiotik yang sedang dikonsumsi. Terapi ini biasanya melibatkan empat macam obat antibakteri yang dikonsumsi selama dua bulan. Jika diperlukan bisa diperpanjang hingga diperoleh hasil tes. Jika terbukti terdapat kekebalan obat, kombinasi pengobatan harus diubah

b. Pengobatan Pengawasan Langsung atau DOT (*Direct Observed Therapy*).

Perawatan ini dilakukan dengan mengawasi pasien secara ketat oleh dokter yang datang setiap kali mereka mengonsumsi obat. Kunjungan khusus ini membantu memastikan bahwa semua dosis antibiotik yang diresepkan telah dikonsumsi (Fitriani, 2020).

C. Pencegahan Tuberkulosis

Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI, 2010) menjelaskan tentang pencegahan penularan penyakit TB, yaitu pada keluarga dan masyarakat sebagai berikut:

1. Makan-makanan yang bergizi seimbang sehingga daya tahan tubuh meningkat.
2. Tidur dan istirahat yang cukup.
3. Lingkungan yang bersih baik tempat tinggal dan sekitarnya.
4. Membuka jendela agar sinar matahari masuk di semua ruangan rumah karena kuman TB akan mati bila terkena sinar matahari.
5. Imunisasi BCG bagi balita.
6. Menyarankan apabila ada salah satu keluarga yang dicurigai gejala tuberkulosis agar segera memeriksakan diri dan berobat sesuai aturan sampai sembuh.

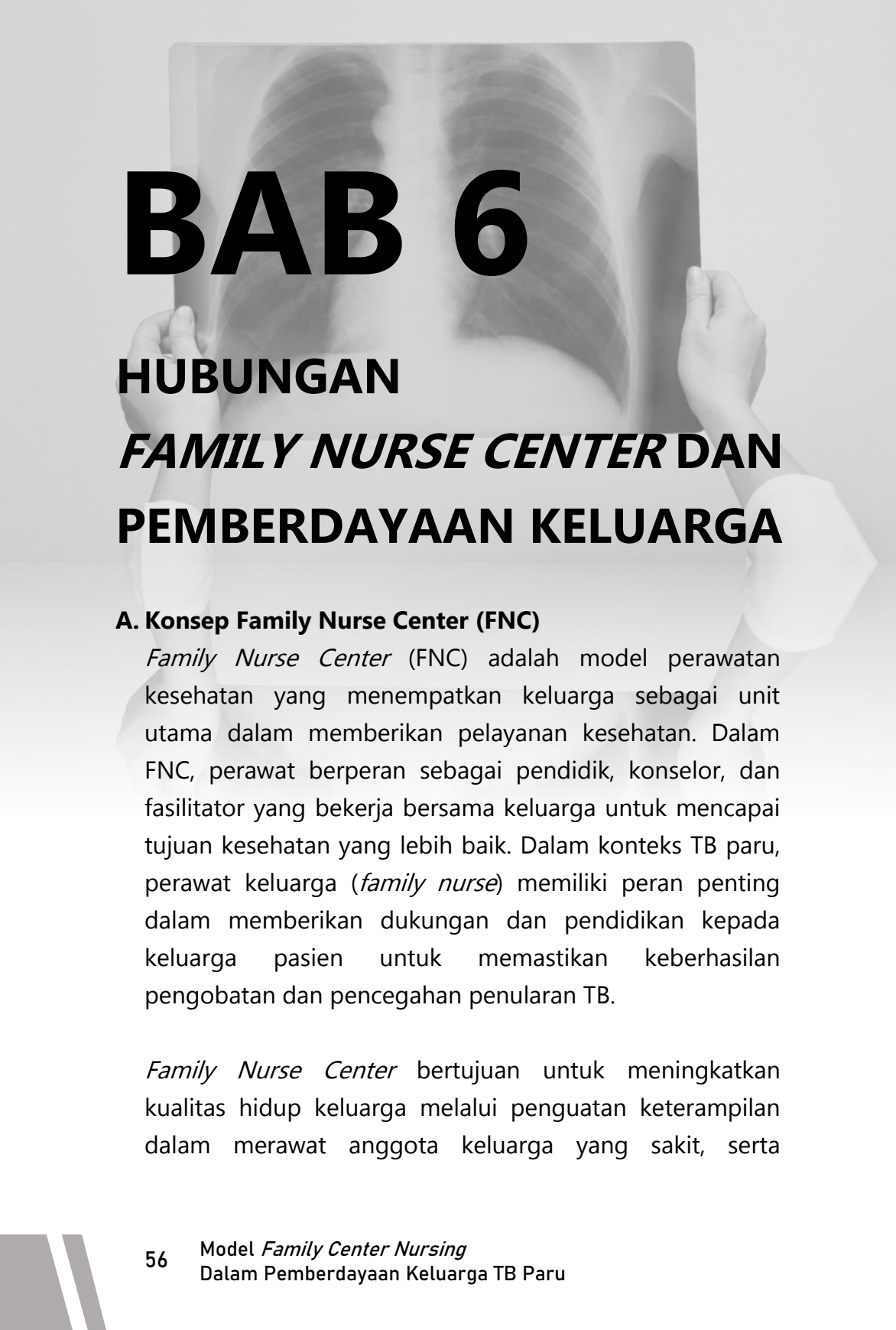
Sedangkan menurut Kemenkes (2015), tindakan pencegahan penularan tuberculosis pada keluarga dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Berperilaku hidup bersih dan sehat dengan rutin mencuci tangan.
2. Keluarga mengajarkan pentingnya penggunaan masker oleh penderita.
3. Menjaga ventilasi rumah. Ventilasi mempunyai banyak fungsi yaitu untuk menjaga aliran udara di dalam rumah sehingga tetap segar, menjaga agar sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Cahaya

matahari dapat membunuh bakteri TB, sehingga rumah yang baik diperlukan cukup cahaya sinar matahari, bakteri TB akan cepat mati bila terkena sinar matahari langsung.

4. Menjemur bantal, guling dan kasur pasien TB untuk pencegahan penularan TB ke anggota keluarga yang lain dan untuk membunuh kuman TB yang mungkin tertinggal.
5. Keluarga mengajarkan etika batuk pada pasien tuberkulosis dengan menutup mulut pada waktu batuk atau bersin. Pentingnya mengingatkan pasien penderita TB untuk menutup mulut agar saat batuk, kuman TB tidak menyebar ke udara dan dapat menyebabkan penularan.
6. Memisahkan alat makan dan minum antara penderita TB dengan keluarga seperti sendok, garpu, piring dan gelas perlu dipisahkan untuk mencegah penularan TB ke anggota keluarga lainnya.
7. Menjemur kasur 1 minggu sekali.
8. Penderita TB diajarkan agar tidak meludah disembarang tempat. Jadi dahak penderita harus ditampung dalam wadah khusus, tertutup dan diberi desinfektan, dahak dapat dibuang di WC dan disiram desinfektan seperti wipol agar dahak tidak tersebar kemana-mana.
9. Tidak tukar menukar peralatan mandi terutama sikat gigi.
10. Keluarga menjaga daya tahan tubuh dengan makan, makanan bergizi, olahraga secara teratur.

11. Keluarga memastikan penderita TB berobat sampai sembuh.
12. Memberikan imunisasi BCG jika ada bayi di rumah.



BAB 6

HUBUNGAN

***FAMILY NURSE CENTER* DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA**

A. Konsep Family Nurse Center (FNC)

Family Nurse Center (FNC) adalah model perawatan kesehatan yang menempatkan keluarga sebagai unit utama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam FNC, perawat berperan sebagai pendidik, konselor, dan fasilitator yang bekerja bersama keluarga untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih baik. Dalam konteks TB paru, perawat keluarga (*family nurse*) memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan pendidikan kepada keluarga pasien untuk memastikan keberhasilan pengobatan dan pencegahan penularan TB.

Family Nurse Center bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui penguatan keterampilan dalam merawat anggota keluarga yang sakit, serta

mendukung keluarga dalam menjalankan pengobatan yang diperlukan, (Cameron & Lown, 2021).

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya yang berkumpul dan tinggal dalam suatu rumah tangga. Jika salah satu atau beberapa anggota keluarga mempunyai masalah kesehatan akan mempengaruhi anggota keluarga lain dan keluarga yang ada di sekitarnya. Salah satu penyakit yang sering dijumpai pada keluarga adalah Tuberkulosis (TB) paru dan penyembuhannya memerlukan perawatan serta perhatian dari anggota keluarga lainnya. Penyembuhan TB paru membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena itu peran keluarga dalam perawatan penderita sangat penting.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Jhonson, 2009). Keluarga merupakan bagian masyarakat yang fundamental bagi kehidupan pembentukan kepribadian anak manusia. Tidak ada satupun lembaga kemasyarakatan yang lebih efektif di dalam membentuk keperibadian anak selain keluarga. Keluarga tidak hanya membentuk anak secara fisik tetapi juga berpengaruh secara psikologis.

Penyakit TB paru yang diderita oleh individu dalam kehidupannya akan membawa dampak negatif, baik secara fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Menurut Depkes, RI (2007), sekitar 75% penderita TB adalah kelompok usia yang paling produktif secara ekonomis (15-50 tahun). Diperkirakan seorang penderita TB dewasa, akan kehilangan rata-rata waktu kerjanya 3 sampai 4 bulan. Hal tersebut berakibat pada kehilangan pendapatan tahunan rumah tangga sekitar 20-30%. Jika ia meninggal akibat TB, maka akan kehilangan pendapatan sekitar 15 tahun. Selain merugikan secara ekonomis, TB juga memberikan dampak buruk lainnya secara sosial stigma bahkan dikucilkan oleh masyarakat.

Menurut Miller (2008) adanya penolakan dan rasa malu sering mencegah orang yang mencari pengobatan dan menyelesaikan pengobatan. Selama ini, pelaksanaan perawatan, pengobatan dan pencegahan penularan TB paru lebih banyak dilakukan kepada penderita TB sendiri. Penderita harus bertanggung jawab atas semua perawatan dan pengobatannya untuk kesembuhannya. Keterlibatan anggota keluarga masih kurang optimal atau hanya sebagai PMO (Pengawas Menelan Obat). Keluarga seringkali tidak mengetahui tindakan yang seharusnya mereka lakukan untuk membantu proses penyembuhan dan pencegahan penyakit TB paru. Jikapun ada pelibatan keluarga dalam perawatan TB di rumah, hal tersebut belum disertai dengan pemberian bekal pengetahuan yang memadai terkait tindakan yang harus dilakukan

keluarga oleh tenaga kesehatan. Menurut Pohan (2007), jika pemberian informasi kesehatan kepada keluarga kurang jelas, pasien dan keluarga kembali ke rumah dengan ketidakpuasan karena tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas dari petugas kesehatan. Kurang optimalnya peran keluarga dalam memberikan perawatan dan pencegahan penularan penyakit TB sering berdampak terhadap anggota keluarga lainnya.

Penderita TB dapat menularkan penyakit kepada anggota keluarga maupun orang yang ada di sekitarnya, akibatnya jumlah penderita TB paru cenderung meningkat. Menurut Depkes RI (2007) pada waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam percikan dahak (droplet nuclei). Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak. Setiap satu BTA positif akan menularkan kepada 10-15 orang lainnya (Widoyono, 2008). Menurut Friedman dalam Suprayitno (2004) tugas keluarga di bidang kesehatan antara lain adalah mengenal masalah kesehatan keluarga, memutuskan tindakan yang tepat, merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan, memodifikasi lingkungan yang menunjang kesehatan dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan. Permasalahan kesehatan maupun keperawatan yang dialami oleh keluarga dapat teratasi jika keluarga mempunyai kemampuan dalam melaksanakan ke lima tugas kesehatan keluarga. Anggota keluarga perlu diberdayakan dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga agar tidak terjadi kesalahan dalam perawatan

penderita di rumah. Oleh karena itu pemberdayaan keluarga dilakukan dengan melibatkan tenaga kesehatan dan sistem pendukungnya dari penderita TB paru. Pemberdayaan keluarga adalah merupakan suatu proses atau upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan kemauan keluarga dalam memelihara dan meningkatkan status kesehatan (Notoatmodjo, 2007).

Menurut Kemenkes RI (2011) keluarga dan penderita TB perlu diberdayakan melalui pemberian informasi yang memadai tentang TB dan pentingnya upaya pencegahan dan pengendalian TB. Pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan pemberian informasi tentang perawatan, pengobatan dan pencegahan penularan penyakit TB Paru, diharapkan dapat merubah perilaku keluarga yang meliputi menumbuhkan aspek pengetahuan, pemahaman, perubahan sikap dan tindakan, kesadaran kesehatan terhadap anggota keluarga dalam perawatan, pengobatan dan pencegahan penularan penyakit TB Paru. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang cara-cara memelihara dan meningkatkan kesehatan adalah awal dari pemberdayaan kesehatan yang selanjutnya menimbulkan kemauan atau kehendak untuk melaksanakan tindakan kesehatan sehingga keluarga dapat melaksanakan tindakan untuk berperilaku sehat. Melalui pemberdayaan keluarga yang merupakan upaya persuasi diharapkan keluarga mau melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Perubahan atau tindakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan

yang dihasilkan didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran melalui proses pembelajaran, sehingga perilaku tersebut diharapkan dapat berlangsung lama dan menetap karena didasari dengan kesadaran.

Menurut teori Kurt Lewin, 1970 dalam Notoatmodjo (2007) yang mengatakan bahwa perubahan pengetahuan pada dasarnya merupakan proses belajar, dan proses belajar akan lebih efektif apabila stimulus yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individu, dilakukan secara intensif dan berkala atau berkelanjutan. Dilakukan 3 (tiga) kali kunjungan rumah kepada keluarga penderita TB paru pada kelompok perlakuan, memungkinkan adanya keberlanjutan dalam proses belajar, serta memungkinkan komunikasi dua arah hingga bila masih ada hal yang masih belum dipahami oleh keluarga, maka memungkinkan dilakukan pengulangan kembali terhadap materi belajar sebelumnya, hingga keluarga benar-benar sudah paham benar tentang materi yang disampaikan, meliputi pengertian penyakit TB, penyebab, cara penularan, tanda dan gejala, pengobatan, cara mencegah penularan, lingkungan rumah yang sehat.

Kesadaran dan keinginan keluarga agar penderita TB dapat sembuh dari penyakitnya merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan mengenal masalah kesehatan, hal ini sesuai dengan teori Health Belief Model yaitu pada kerentanan yang dirasakan (*perceived susceptibility*) yaitu agar seseorang bertindak untuk

mengobati atau mencegah penyakitnya, ia harus merasakan bahwa ia rentan terhadap penyakit tersebut dengan kata lain suatu tindakan pencegahan terhadap suatu penyakit akan timbul bila seseorang telah merasakan bahwa ia atau keluarganya rentan terhadap penyakit tersebut (Glanz, Karen 2008).

Kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan untuk tindakan yang tepat terhadap penderita TB Paru merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan pertimbangan siapa diantara anggota keluarga yang mempunyai kemampuan memutuskan untuk menentukan tindakan keluarga dalam hal mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga. Tindakan kesehatan yang dilakukan keluarga diharapkan tepat agar kesehatan masalah dapat dikurangi atau bahkan teratasi.

Menurut Sudiharto (2007), untuk mengambil keputusan untuk mencari pertolongan karena menonjolnya suatu masalah yang dirasakan oleh keluarga. Keluarga memandang masalah keperawatan berkaitan dengan berat dan mendesaknya masalah tersebut segera diatasi. Beberapa cara pandang keluarga dan berkaitan dengan pengambilan keputusan adalah masalah dirasakan berat dan harus segera diatasi, masalah dirasakan tetapi tidak perlu segera diatasi, dan atau masalah tidak dirasakan sama sekali oleh keluarga. Faktor budaya juga dapat

mempengaruhi keluarga dalam mengambil keputusan tindakan. Menurut Foster (1973) dikutip dari Notoatmodjo (2005) menyebutkan bahwa aspek budaya dapat mempengaruhi kesehatan seseorang antara lain adalah tradisi, sikap fatalism, nilai, ethnocentrism dan unsur budaya dipelajari pada tingkat awal dalam proses sosialisasi. Salah satu budaya di Kabupaten Banjar adalah barunding (musyawarah) dengan keluarga yang lain. Kadangkadang seorang penderita dengan kondisi yang sudah parah terlambat mendapatkan pertolongan hanya karena harus menunggu keluarga lainnya datang untuk memutuskan tindakan.

Jika penderita TB paru mengeluh tidak ada nafsu makan, perut mual atau sakit perut ketika beberapa saat minum obat keluarga juga tidak mampu memberitahukan kepada penderita agar tetap meminum obat tetapi pada malam hari sebelum tidur. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga belum mampu melakukan perawatan kepada penderita akibat efek samping dari obat anti TB. Menurut Depkes RI (2007) salah satu efek samping yang ditimbulkan oleh obat anti TB adalah tidak ada nafsu makan, mual, sakit perut yang disebabkan oleh obat Rifampisin, dan dapat diatasi dengan meminum obat pada malam hari sebelum tidur. Demikian juga dengan kemampuan keluarga tentang pencegahan penularan ketika penderita TB batuk, banyak keluarga menjawab membiarkan saja atau menghindar dan menjauhi penderita, semestinya keluarga harus mengingatkan kepada penderita TB yang sedang

batuk di lingkungan rumah dengan menutup mulut dengan sapu tangan/tissue dengan demikian risiko penularan penyakit dapat dihindari. Ketidakmampuan keluarga dalam memberikan perawatan pada keluarga yang sakit dapat disebabkan oleh kurangnya informasi tentang konsep penyakit, pengobatan, perawatan dan pencegahan penularan penyakit TB paru yang dapat berdampak terhadap perilaku kesehatan keluarga, meningkatkan risiko penularan dan kambuhnya penyakit bahkan menimbulkan kematian.

Petugas kesehatan yang ada di Puskesmas khususnya yang menangani program pemberantasan TB paru seringkali tidak memberikan informasi yang cukup kepada penderita maupun keluarganya, informasi yang diberikan hanya sekitar pemeriksaan dahak, rontgen, cara minum obat dan kapan harus kontrol kembali ke Puskesmas. Menurut Pohan (2007), jika pemberian informasi kesehatan kepada keluarga kurang jelas, pasien dan keluarga kembali ke rumah dengan ketidakpuasan karena tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas dari petugas kesehatan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat WHO yang menyebutkan bahwa untuk merubah perilaku diperlukan strategi diantaranya adalah dengan melalui cara pemberian informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara menghindari penyakit dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya dengan pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran

mereka, dan pada akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Perubahan yang akan dicapai akan bersifat langgeng karena didasari oleh kesadaran dan bukan karena paksaan (Notoatmodjo, 2007).

B. Pemberdayaan Keluarga dalam *Family Nurse Center*

Pemberdayaan keluarga dalam model FNC bertujuan untuk mengaktifkan keluarga dalam pengambilan keputusan terkait perawatan kesehatan, memberikan dukungan emosional, dan memastikan kepatuhan terhadap pengobatan. Dalam hal TB paru, pemberdayaan ini melibatkan keluarga dalam:

1. Edukasi tentang penyakit dan pengobatan.
2. Pengawasan pengobatan langsung (DOT).
3. Pencegahan penularan dalam rumah tangga.

Pemberdayaan keluarga yang didukung oleh perawat keluarga terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan mengurangi angka penularan TB dalam komunitas, Sari et al (2020) & Lestari et al (2022).

Dalam praktik keperawatan di komunitas dan keluarga, aspek lingkungan menjadi salah satu prioritas yang penting dalam upaya penyembuhan penyakit, beberapa penyakit dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan yang tidak sehat sehingga untuk mencegah timbulnya penyakit diperlukan lingkungan yang sehat dan nyaman. Teori keperawatan yang dapat direkomendasikan dan

sesuai dengan kondisi penyakit TB paru adalah teori yang dikemukakan oleh Florence Nightingale yang mengutamakan pada aspek lingkungan dalam penerapannya. Teori Florence Nightingale menyakini kondisi lingkungan yang sehat penting untuk penanganan perawatan yang layak. Komponen lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan antara lain udara segar, air bersih, saluran pembuangan yang efisien, kebersihan dan cahaya (Tomey & Alligood, 2006).

Aspek lingkungan yang diutamakan Nightingale dalam merawat penderita adalah ventilasi yang cukup bagi penderita. Ia berkeyakinan bahwa ketersediaan udara segar secara terus menerus merupakan prinsip utama dalam keperawatan. Oleh sebab itu setiap keluarga diharapkan dapat menjaga udara yang dihirup penderita tetap bersih, sebersih udara luar tanpa harus membuatnya kedinginan. Komponen lain yang tidak kalah penting dalam keperawatan penderita adalah cahaya matahari. Nightingale yakin sinar matahari dapat memberi manfaat yang besar bagi kesehatan penderita. Hal ini sesuai dengan Depkes RI (2002) yang menyebutkan bahwa kuman tuberkulosis hanya dapat mati oleh sinar matahari langsung. Menurut (Crofton, 1999) seseorang dapat tertular penyakit TB paru jika terdapat faktor risiko sebagai berikut:

1. Kontak serumah dengan penderita TBC BTA (+).
2. Lingkungan: ventilasi yang kurang, kepadatan penduduk.

3. Menderita HIV, malnutrisi, penyakit DM, immuno-supresan.
4. Perilaku tidak sehat.

Menurut Depkes RI 2002 Data Lingkungan diantaranya

1. Karakteristik Rumah

Dimana keadaan rumah yang sempit, ventilasi kurang, udara yang lembab termasuk rumah dengan kondisi di bawah standar Kesehatan. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan kuman tuberculosis bertahan hidup adalah kondisi udara yang lembab

2. Karakteristik lingkungan

Lingkungan rumah yang bersih, pembuangan sampah, dan pembuangan limbah yang benar dapat mengurangi penularan TBC dan menghambat pertumbuhan bakteri tuberkulosa. TBC sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan yang kotor.

3. Perkumpulan Keluarga dan Interaksi dengan Masyarakat

Kuman Tuberculosis dapat menular dari udara. Semakin sering kontak langsung dengan penderita beresiko sekali tertular TBC. Terutama yang merawat di rumah berkesempatan terkena TBC dari pada yang berada di tempat Umum.

Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas kesehatan dapat disebabkan karena beberapa alasan, misalnya letak fasilitas kesehatan yang jauh, petugas yang kurang ramah dan tidak responsive, penderita takut dengan dokter, biaya dan lain-lain. Dalam penelitian ini, beberapa keluarga

menjawab jika ada keluarga yang sakit usaha yang mereka lakukan adalah mengobati sendiri dengan membeli obat di warung atau tidak diobati karena dapat sembuh sendiri dan jika tidak sembuh dengan pengobatan sendiri mereka membawa keluarga yang sakit dengan pengobatan tradisional pada tabib atau ulama (tuan guru). Perilaku sebagian masyarakat atau keluarga menggunakan pertolongan kepada seorang yang bukan petugas kesehatan dengan melakukan pengobatan tradisional berhubungan dengan keberadaan mereka yang ada di tengah-tengah masyarakat, dekat dengan Masyarakat dan pengobatan yang dihasilkan adalah kebudayaan masyarakat lebih diterima oleh masyarakat daripada dokter, perawat atau bidan.

Persepsi sehat sakit keluarga dengan persepsi sehat sakit menurut petugas kesehatan (perawat) dapat berbeda. Menurut Notoatmodjo (2007), persepsi masyarakat terhadap sehat sakit erat hubungannya dengan perilaku pencarian pengobatan yang akan mempengaruhi dipakai atau tidak dipakainya fasilitas kesehatan yang disediakan. Apabila persepsi sehat sakit masyarakat belum sama dengan konsep sehat sakit kita maka jelas masyarakat belum tentu atau tidak mau menggunakan fasilitas yang diberikan.

C. Peran Keluarga dalam Pengobatan TB Paru

Keluarga merupakan salah satu peran pendukung bagi penderita TBC yaitu dengan melalui Struktur keluarga antara lain:

1. Pola Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga yang terjadi secara terbuka dan dua arah akan sangat mendukung bagi penderita TBC, saling mengingatkan dan memotivasi penderita untuk terus melakukan pengobatan dapat mempercepat proses penyembuhan.

2. Struktur Peran Keluarga

Bila anggota keluarga dapat menerima dan melaksanakan perannya dengan baik akan membuat anggota keluarga puas dan menghindari terjadinya konflik dalam keluarga dan Masyarakat.

3. Struktur Kekuatan Keluarga

Kemampuan anggota keluarga untuk memengaruhi dan mengendalikan orang lain untuk mengubah perilaku keluarga yang mendukung kesehatan. Penyelesaian masalah dan pengambilan Keputusan secara musyawarah dapat menciptakan suasana kekeluargaan sehingga akan timbul perasaan dihargai dalam keluarga.

4. Nilai dan Norma Keluarga

Perilaku individu masing-masing anggota keluarga yang di tampilkan merupakan gambaran dari nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga.

Fungsi Keluarga menurut Friedman (2003) ada 5 yaitu:

1. Fungsi afektif

Keluarga yang saling menyayangi dan peduli terhadap anggota keluarga yang sakit TBC akan mempercepat proses penyembuhan karena adanya partisipasi dari keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit.

2. Fungsi Sosialisasi dan Tempat Bersosialisasi

Fungsi keluarga mengembangkan dan melatih untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain. Tidak ada Batasan dalam bersosialisasi bagi penderita dengan lingkungan akan memengaruhi kesembuhan penderita asalkan penderita tetap memperhatikan kondisinya. Sosialisasi sangat diperlukan karena dapat mengurangi stress bagi penderita.

3. Fungsi Perawatan/ Pemeliharaan Kesehatan

Dikaitkan dengan kemampuan keluarga dalam melaksanakan lima tugas keluarga di bidang Kesehatan, yaitu:

a. Mengetahui masalah Kesehatan keluarga

Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak boleh diabaikan karena tanpa Kesehatan segala sesuatu tidak akan berarti dan karena kesehatanlah terkadang seluruh kekuatan sumber daya dan dana keluarga habis. Ketidak sanggupan keluarga dalam mengetahui masalah Kesehatan pada keluarga salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan keluarga

tentang pengertian, tanda dan gejala, akibat, pencegahan, perawatan, dan pengobatan TBC.

- b. Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga

Ketidaksanggupan keluarga mengambil keputusan dalam melakukan tindakan yang tepat disebabkan keluarga tidak memahami mengenai dampak atau konsekuensi, berat dan luasnya masalah serta tidak merasakan menonjolnya masalah. Tugas ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan mempertimbangkan siapa di antara keluarga yang mempunyai kemampuan memutuskan menentukan tindakan keluarga. Tindakan kesehatan yang dilakukan oleh keluarga diharapkan tepat agar masalah kesehatan dapat dikurangi, bahkan teratasi.

- c. Merawat keluarga yang mengalami gangguan Kesehatan

Keluarga dapat mengambil tindakan yang tepat dan benar, tetapi keluarga memiliki keterbatasan. Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit dikarenakan tidak mengetahui cara perawatan terhadap penyakit. Jika demikian, anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan perlu memperoleh tindakan lanjutan atau perawatan dapat dilakukan di institusi pelayanan kesehatan.

- d. Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga

Pemeliharaan lingkungan yang baik, lingkungan fisik dan psikologis (dukungan anggota keluarga) akan meningkatkan kesehatan keluarga dan membantu penyembuhan. Ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber keluarga di antaranya keuangan dan kondisi fisik rumah yang tidak memenuhi syarat.

- e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi keluarga

Kemampuan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan akan membantu anggota keluarga yang sakit memperoleh pertolongan dan mendapat perawatan segera agar masalah teratasi.

4. Fungsi Reproduksi

Keluarga berfungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. Keluarga juga sebagai tempat untuk mengembangkan fungsi reproduksi secara universal, di antaranya: seks yang sehat dan berkualitas, serta pendidikan seks pada anak sangat penting.

5. Fungsi Ekonomi

Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan makan, pakaian, dan tempat untuk berlindung (rumah) juga sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Faktor utama yang mendukung berlanjutnya kemauan menjadi tindakan adalah sarana dan prasarana untuk mendukung tindakan. Menurut teori Lawrence Green (1980) dikutip oleh Notoadmodjo (2007), untuk dapat terwujudnya perilaku hidup sehat ditunjang oleh faktor:

1. Faktor predisposisi (*Predisposing factors*), faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap keluarga terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan keluarga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut di masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi.
2. Faktor Pemungkin (*Enabling Factors*), faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk perilaku sehat keluarga memerlukan sarana dan prasarana pendukung, misalnya Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Dokter praktik, Klinik perawatan.
3. Faktor Penguat (*Reinforcing factors*), faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat (toma), tokoh agama (toga), sikap dan perilaku petugas kesehatan termasuk perawat, undang-undang, peraturanperaturan baik dari pusat maupun dari daerah yang terkait dengan kesehatan.

Berkaitan dengan faktor penguat (*Reinforcing factors*), peran serta tokoh masyarakat masih belum dioptimalkan dalam upaya pemberantasan penyakit TB paru, padahal tokoh masyarakat merupakan panutan sebagai orang yang dapat dicontoh dari perkataan maupun tingkah lakunya.

Sementara itu tenaga kesehatan (perawat) yang bertanggung jawab dalam program pemberantasan TB paru harus benarbenar fokus menjalankan tugasnya dan diharapkan mempunyai cukup waktu serta tenaga untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita tetapi yang terjadi pada salah satu Puskesmas, penanggung jawab pemberantasan TB paru justru dibebani tugas tambahan lain yang menyebabkan beban kerjanya lebih meningkat. Kesempatan untuk memberikan informasi kepada penderita maupun keluarga saat kunjungan ke Puskesmas menjadi terbatas, akibatnya penderita dan keluarga tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang penyakit TB paru.

Menurut Graef (1996) yang menggambarkan model perubahan perilaku secara bertahap dimulai dengan tahap pre komtemplasi di mana pada observasi awal (sebelum pemberdayaan) keluarga belum memikirkan sama sekali untuk melakukan tugas kesehatan keluarga dan belum bermaksud untuk merubah perilakunya. Pada tahap komtemplasi keluarga sudah siap merubah perilakunya setelah diberikan pemberdayaan melalui penyuluhan, demonstrasi dan pelatihan tentang cara perawatan dan pencegahan penularan TB paru di rumah. Memasuki tahap aksi keluarga sudah dapat melaksanakan tugas kesehatan keluarga meliputi kemampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan TB Paru, kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan untuk tindakan yang tepat terhadap penderita TB Paru, kemampuan keluarga dalam memberi

perawatan kepada keluarga yang sakit TB Paru, kemampuan keluarga dalam mempertahankan lingkungan fisik rumah yang menunjang kesehatan, kemampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat. Sedangkan pada tahap pemeliharaan, keluarga mempertahankan perilaku baru yang mempengaruhi proses penyembuhan penderita TB paru.

Keluarga memegang peran yang sangat penting dalam pengobatan Tuberkulosis (TB) paru, terutama karena TB paru adalah penyakit menular yang membutuhkan pengobatan jangka panjang dan kepatuhan yang tinggi. Peran keluarga meliputi dukungan emosional, sosial, dan fisik untuk pasien, serta pengawasan terhadap pengobatan yang dijalani.

D. Peran *Family Nurse Center* dalam Pengobatan TB Paru

Perawat keluarga berperan penting dalam membantu keluarga memahami penyakit TB serta perawatan yang harus dilakukan, berfungsi sebagai mediator antara pasien, keluarga, dan sistem pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa keluarga dapat memberikan dukungan yang efektif bagi pasien. Peran perawat keluarga dalam FNC sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan keluarga dalam perawatan TB dan mendukung keberhasilan pengobatan jangka panjang, Suhartono (2023).

E. Integrasi *Family Nurse Center* dengan Pemberdayaan Keluarga dalam TB Paru

Integrasi antara *Family Nurse Center* dan pemberdayaan keluarga dalam pengobatan TB paru dapat menghasilkan:

1. Peningkatan kualitas hidup pasien dengan dukungan emosional dan fisik dari keluarga.
2. Peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan melalui pengawasan langsung dari keluarga.
3. Pengurangan penularan TB melalui penerapan prinsip pencegahan yang tepat dalam rumah tangga.

Pemberdayaan keluarga melalui *Family Nurse Center* menunjukkan dampak positif pada pengurangan penularan TB serta meningkatkan efektivitas pengobatan yang diterima pasien, Prasetyo & Alamsyah (2021) dan Sari dkk (2022).



BAB 7

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tuberkulosis paru (TB Paru) masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang memerlukan pendekatan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu aspek yang krusial dalam pengendalian TB Paru adalah kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan yang bersifat jangka panjang dan sering kali menimbulkan efek samping. Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, pendekatan *Family Centered Nursing* (FCN) terbukti relevan dan efektif dalam mendukung keberhasilan terapi TB Paru, khususnya melalui pemberdayaan keluarga. FCN mengedepankan peran aktif keluarga dalam proses perawatan pasien, tidak hanya sebagai pendukung emosional, tetapi juga sebagai mitra dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengobatan harian. Dengan melibatkan keluarga secara langsung dalam proses edukasi, pemantauan, serta penguatan psikososial, model ini mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesembuhan pasien.

Pemberdayaan keluarga melalui pendekatan FCN memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan literasi kesehatan keluarga, membangun sikap kooperatif terhadap terapi, dan memperkuat komitmen kolektif dalam mendampingi anggota keluarga yang menderita TB Paru. Di tengah tantangan sosial seperti stigma, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya akses informasi, FCN hadir sebagai pendekatan humanistik yang menempatkan keluarga sebagai pusat dukungan dan intervensi. Keterlibatan keluarga bukan hanya meningkatkan efikasi pengobatan secara langsung, tetapi juga memperbaiki aspek sosial dan psikologis pasien, yang kerap menjadi faktor tersembunyi penyebab ketidakpatuhan. Dengan demikian, FCN tidak hanya berorientasi pada aspek klinis, tetapi juga memperluas dimensi pemulihan ke ranah kesejahteraan holistik.

B. Saran

Pengoptimalan implementasi model *Family Centered Nursing* dalam konteks pengobatan TB Paru, sangat diperlukan adanya dukungan sistematis dari institusi pelayanan kesehatan dan pembuat kebijakan. Penerapan FCN sebaiknya tidak hanya menjadi pilihan pendekatan, tetapi diintegrasikan sebagai bagian dari standar pelayanan TB di fasilitas kesehatan, terutama di tingkat primer. Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan komunikasi, serta sensitivitas sosial-budaya yang memadai untuk melibatkan keluarga

secara efektif dalam proses perawatan pasien TB Paru. Tenaga kesehatan perlu memahami bahwa pendekatan FCN bukan hanya menyampaikan informasi kepada keluarga, tetapi juga membangun hubungan kemitraan yang bersifat dua arah dan saling memperkuat.

Di samping itu, perlu dikembangkan berbagai bentuk media edukatif yang sesuai dengan latar belakang sosial dan tingkat literasi masyarakat, agar keluarga dapat memahami secara komprehensif mengenai TB Paru, proses pengobatan, serta peran yang dapat mereka jalankan. Keterlibatan tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta organisasi kemasyarakatan juga dapat menjadi strategi kolaboratif untuk memperluas jangkauan penerapan FCN. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan memberikan dukungan kebijakan berupa alokasi anggaran, insentif untuk kader, serta penguatan sistem rujukan yang mendukung keberlanjutan intervensi berbasis keluarga ini.

Akhirnya, untuk memperkuat landasan ilmiah dari model FCN dalam konteks TB Paru, dibutuhkan penelitian lanjutan yang bersifat longitudinal dan kuantitatif dengan melibatkan sampel yang lebih luas dan beragam. Studi-studi tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi FCN, sehingga model ini dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan berbagai konteks sosial dan geografis di Indonesia. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan dukungan lintas sektor, diharapkan

bahwa FCN dapat menjadi bagian penting dalam strategi nasional pemberantasan TB dan peningkatan kualitas hidup pasien serta keluarganya.

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam pengembangan praktik keperawatan berbasis keluarga, khususnya dalam konteks penanganan Tuberkulosis Paru. Penerapan Model *Family Centered Nursing* diharapkan mampu menjadi pendekatan strategis dalam meningkatkan peran aktif keluarga sebagai pendukung utama pasien, sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan TB Paru.

Melalui penjabaran konsep, implementasi, serta refleksi dari pendekatan ini, penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi bermanfaat bagi tenaga kesehatan, akademisi, dan mahasiswa keperawatan dalam upaya meningkatkan efektivitas intervensi keperawatan di ranah komunitas.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi kedalaman kajian maupun pengalaman empiris yang dijadikan dasar. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu sumber inspirasi dalam pengembangan praktik keperawatan komunitas yang lebih holistik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- American Academy of Pediatric. (2012). Family Centered Care and The Pediatrician's Role. Journal of American Academic of Pediatric. Volume 112. Page 691 - 696 <http://www.aappublications.org/egl/reprint/pediatrics;112/3/691.pdf>.
- American Academy of Pediatrics Committee on Hospital Care. (2012). Family-centered care and the pediatrician's role. Pediatrics, 112, 691–697.
- Atmanto GE, Maranatha D. Seorang Wanita dengan Tb Paru Kasus Baru dan Tb Ekstra Paru Multiple. J Respirasi. 2019;5(1):10–4. <https://doi.org/10.20473/jr.v5-I.1.2019.10-14>
- Baral, S. C., Karki, D. K., & Newell, J. N. (2007). Causes of stigma and discrimination associated with tuberculosis in Nepal: A qualitative study. BMC Public Health, 7, 1–10. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-7-211>
- Basaza, R., et al. (2020). *Determinants of Non-Adherence to Tuberculosis Treatment in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review*. BMC Public Health.
- Beach, S. R., & Schulz, R. (2017). Family Caregiver Factors Associated with Unmet Needs for Care of Older Adults. Journal of the American Geriatrics Society, 65(3), 560–566. <https://doi.org/10.1111/jgs.14547>
- Broekema, S., Paans, W., Roodbol, P. F., & Luttik, M. L. A. (2020). Nurses' application of the components of family nursing conversations in home health care: a qualitative content analysis. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 34(2), 322–331. <https://doi.org/10.1111/scs.12731>
- Cameron, K. A., & Lown, E. A. (2021). The role of Family Nurse Centers in community health: Empowering families for

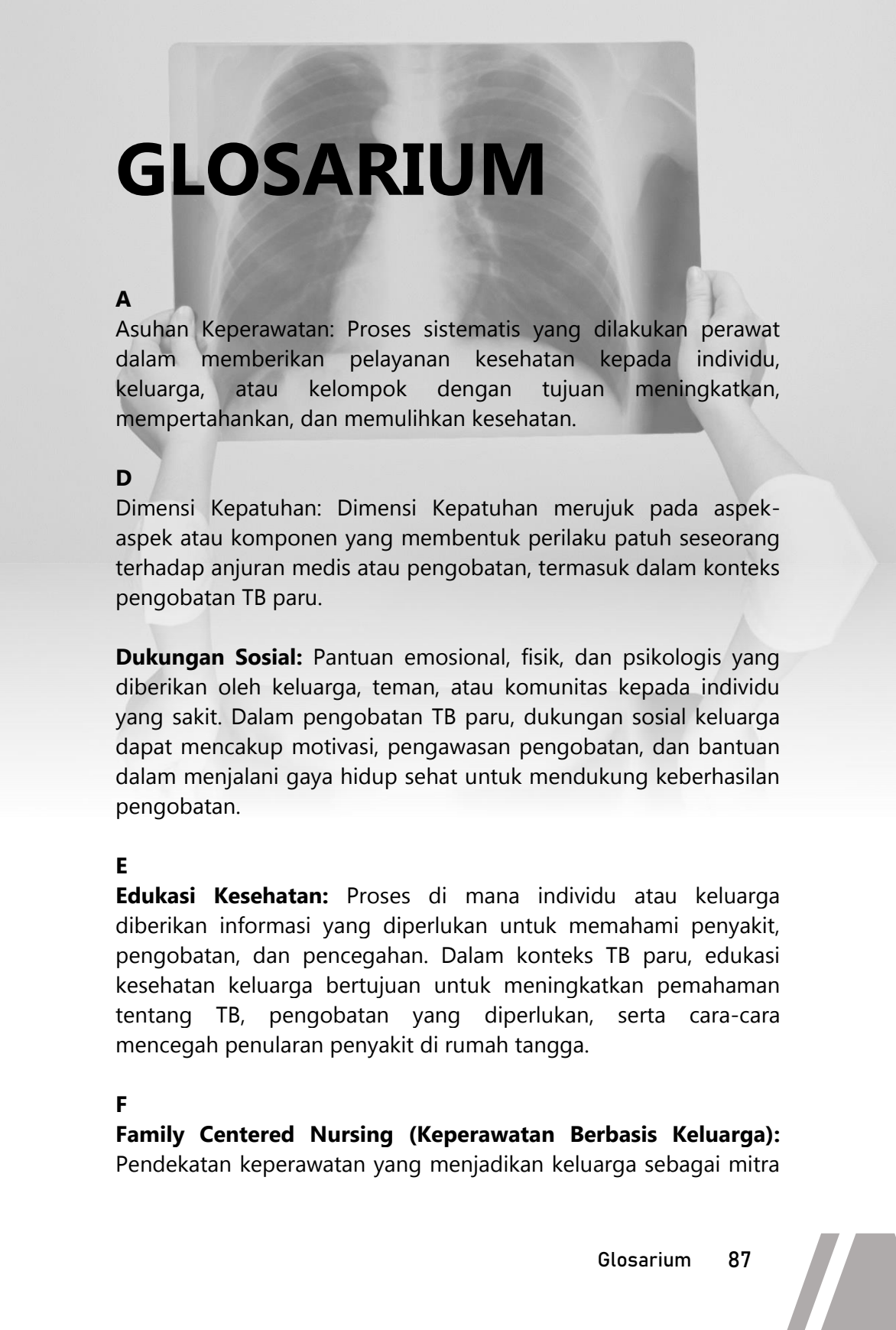
- better health outcomes. *Journal of Community Health Nursing*, 38(2), 78–86.
<https://doi.org/10.1080/07370016.2021.1905001>
- Dinas Kesehatan Prov. Jabar. (2019). The Number of Bacteriologically Confirmed Pulmonary Tuberculosis Cases Registered and Treated by Gender in West Java. <https://opendata.jabarpov.go.id/id/dataset/j-jumlah-kasus-tuberkulosis-paru-terkonfirmasi-bakteriologis-yang-terdaftar-dan-diobatiberdasarkan-jenis-kelamin-di-jawa-barat>.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga Riset, Teori, & Praktik*. EGC.
- Girin Kartika Sari, Sarifuddin & Tri Setyawati, 2022, Tuberkolosis Paru Post WODEC Pleural Efusion : Laporan Kasus Pulmonary Tuberculosis Post WODEC Pleural Efusion : Case Report, *Jurnal Medical Profession (MedPro)* Vol 4. No 2. Juni 2022 medical Profession Program, Faculty Of Medicine, Tadulako University Palu, Indonesia.
- Gebreweld, F., & Kifle, M. (2015). Factors Influencing Adherence to Tuberculosis Treatment in Ethiopia: A Qualitative Study. *Journal of Health, Population and Nutrition*.
- Harjanto AR, Nurdin F, Rahmanoe M. Efusi Pleura Sinistra Masif Et Causa TB pada Anak. *J Major*. 2018;7(3):152–7.
- Hockenberry, M.J. & Wilson, D., 2011, *Wong's Nursing Care of Infants and Children*, 9th ed., Missouri: Elseiver.
- Institute of Medicine. (2012). *Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century*. Washington, DC: The National Academies Press; 2001.
http://www.iom.edu/*/media/Files/Report%20Files/2001/Crossingthe-Quality-Chasm/Quality%20Chasm%202001%20%20report%20brief.pdf. Accessed 6 Jan 2018.

- Kaiser Family Foundation. (2021). The U.S. Government and Global Tuberculosis Efforts. Global Health Policy. https://www.kff.org/global-health-policy/factsheet/the-u-s-government-and-global-tuberculosis-efforts/#endnote_link_513982-2
- Kamitsuru S. Diagnosis Keperawatan: Definisi & Klasifikasi 2015-2016. Edisi 10. 2015: EGC; 2015.
- Kartika, A. W., Wiarsih, W., & Permatasari, H. (2015). Pengalaman Keluarga dalam Merawat Penderita Sakit Kronis. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 18(1), 51–58. <https://doi.org/10.7454/jki.v18i1.398>
- Kementrian Kesehatan RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._67_ttg_Penanggulangan_Tuberkulosis_.pdf
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Infodatin Tuberkulosis 2018 [Internet]. 2018 [cited 2022 Sep 15]. Available from: <https://pusdatin.kemkes.go.id/article/view/18101500001/infodatin-tuberkulosis-2018.html>
- Kristini T, Hamidah R. Potensi Penularan Tuberculosis Paru pada Anggota Keluarga Penderita. *J Kesehatan Masyarakat Indonesia* 2020;15(1):24–8. <https://doi.org/10.26714/jkmi.15.1.2020.24-28>
- Lestari, T. R., Dewi, R. M., & Kartasasmita, C. B. (2022). Peran perawat keluarga dalam pemberdayaan keluarga TB paru untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 9(1), 54–62. <https://doi.org/10.3123/jkk.v9i1.4561>
- Mahdi A, Mohammed B, Hassan A, Yousif A, Zahra A, Meshal A, et al. Evaluation of Tuberculosis Awareness in Eastern and Western Saudi Arabia. 2017;

- Ministry of Health of the Republic of Indonesia. (2021). Make the Future Generation Tuberculosis Free, Starting from Oneself and Family. Kementerian Kesehatan. <https://www.kemkes.go.id/article/view/21032500001/jadikan-penerus-bangsa-bebas-tbcdimulai-dari-diri-sendiri-dan-keluarga.html>
- Muhtar 2023, Pengaruh Pemberdayaan Keluarga Dalam Meningkatkan Self Efficacy Dan Self Care Activity Keluarga Dan Penderita Tuberculosis Paru Di Kota Bima Nusa Tenggara Barat <https://repository.unair.ac.id/122797/>
- Niven, N. (2008). Health psychology: An introduction for nurses and other health care professionals (3rd ed.). Churchill Livingstone.
- Prabawa, P. A., Claramita, M., & Pramantara, I. D. P. (2018). Patients' and families' experiences in Lung Tuberculosis treatment in Kebumen District, Central Java Province: A phenomenology study of 'Drop Out' and 'Uninterrupted' groups. Review of Primary Care Practice and Education (Kajian Praktik Dan Pendidikan Layanan Primer), 1(3), 105. <https://doi.org/10.22146/rpcpe.41692>
- Pralambang SD, Setiawan S. Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis di Indonesia. J Biostat Kependudukan, dan Inform Kesehat. 2021;2(1):60–71. <https://doi.org/10.51181/bikfokes.v2i1.4660>
- Prasetyo, E., & Alamsyah, A. (2021). Model pemberdayaan keluarga dalam pengobatan TB paru: Integrasi antara keluarga dan perawat. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 17(3), 132–140. <https://doi.org/10.24893/jkma.v17i3.5983>
- Puspasari. Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Pernapasan. Yogyakarta: PT Pustaka Baru; 2019. <https://doi.org/10.31227/osf.io/bf8rq>
- Puskesmas Cimanggis. (2021). Coverage of TB at the Cimanggis Community Health Center in 2021.

- Putra TRI, Maya P, Hasan M, Pranata A, Salsabila S, Sariningrum HA. Karakteristik Pasien Efusi Pleura Non-Maligna di RSUD Dr. Zainoel Abidin Tahun 2019. *J Penyakit Dalam Indones*. 2022;9(1):15–22. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v9i1.696>
- Ris, I., Schnepf, W., & Mahrer Imhof, R. (2019). An integrative review on family caregivers' involvement in care of home-dwelling elderly. In *Health and Social Care in the Community* (Vol. 27, Issue 3, pp. e95–e111). <https://doi.org/10.1111/hsc.12663>
- Sari, Elsa Nika, 2022, Gambaran Kepatuhan Warga dalam Penerapan Protokol Kesehatan di RT 04 RW 03 Bandung Rejo Sari Sukun Malanga, <http://repository.itsk-soepraoen.ac.id/745/>
- Sari, M. T., Haflin, H., & Rahmadiyah, D. (2020). Karakteristik dan upaya pencegahan penularan pada penderita tuberkulosis paru. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 692-696.
- Sari, M. T., Putri, M. E., Daryanto, D., Al Fajri, J., Apriyali, A., Vigri, S., & Misyina, M. (2022). Pemberdayaan keluarga dengan pendekatan health coaching pada keluarga sadar dan siaga tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Payo Selincah. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 4(2), 267-273.
- Stones, S. (2020). Family nursing – why and what is it? International Family Nursing Association (IFNA). <https://ifnaukandireland.org/familynursing-why-and-what-is-it/>
- WHO. (2021). Tuberculosis. World Health Organization. <https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/tuberculosis>
- World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2020 [Internet]. 2020 [cited 2022 Sep 15]. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240013131>

World Health Organization. Meeting of the Implementation Core Group of WHO Global Task Force on Latent TB Infection and Country Stakeholders on Implementation Tools and Joint TB and HIV Programming to Scale Up TB Preventive Treatment [Internet]. 2018 [cited 2022 Sep 15]. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CDS-TB-2018.38>



GLOSARIUM

A

Asuhan Keperawatan: Proses sistematis yang dilakukan perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, atau kelompok dengan tujuan meningkatkan, mempertahankan, dan memulihkan kesehatan.

D

Dimensi Kepatuhan: Dimensi Kepatuhan merujuk pada aspek-aspek atau komponen yang membentuk perilaku patuh seseorang terhadap anjuran medis atau pengobatan, termasuk dalam konteks pengobatan TB paru.

Dukungan Sosial: Pantuan emosional, fisik, dan psikologis yang diberikan oleh keluarga, teman, atau komunitas kepada individu yang sakit. Dalam pengobatan TB paru, dukungan sosial keluarga dapat mencakup motivasi, pengawasan pengobatan, dan bantuan dalam menjalani gaya hidup sehat untuk mendukung keberhasilan pengobatan.

E

Edukasi Kesehatan: Proses di mana individu atau keluarga diberikan informasi yang diperlukan untuk memahami penyakit, pengobatan, dan pencegahan. Dalam konteks TB paru, edukasi kesehatan keluarga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang TB, pengobatan yang diperlukan, serta cara-cara mencegah penularan penyakit di rumah tangga.

F

Family Centered Nursing (Keperawatan Berbasis Keluarga): Pendekatan keperawatan yang menjadikan keluarga sebagai mitra

aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan keperawatan, guna meningkatkan hasil kesehatan pasien.

Family Nurse: Perawat yang berperan memberikan layanan kesehatan secara holistik kepada keluarga, dengan fokus pada pencegahan, promosi kesehatan, serta pengelolaan penyakit kronis dan menular di tingkat keluarga dan komunitas.

I

Intervensi Keperawatan: Tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh perawat sebagai respons terhadap masalah kesehatan pasien yang telah diidentifikasi melalui proses pengkajian.

Infeksi Laten: Kondisi saat seseorang terinfeksi *Mycobacterium tuberculosis* tetapi belum menunjukkan gejala TB aktif. Meski tidak menular, dapat berkembang menjadi TB aktif jika tidak dicegah.

K

Keperawatan Komunitas: Bidang keperawatan yang berfokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara luas, melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di tingkat komunitas.

Kepatuhan Pengobatan: Tingkat ketaatan pasien dalam menjalankan regimen terapi yang telah ditetapkan oleh tenaga kesehatan, baik dalam hal dosis, jadwal, maupun durasi pengobatan.

Keterlibatan Keluarga: Partisipasi aktif keluarga dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan intervensi keperawatan atau tindakan medis yang berkaitan dengan kondisi anggota keluarganya.

Komunitas: Kelompok sosial di sekitar keluarga yang dapat mendukung atau memengaruhi upaya pengobatan dan

pencegahan TB, termasuk tetangga, kader kesehatan, dan petugas puskesmas.

Kualitas Hidup: Kondisi kesejahteraan pasien secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, yang dapat dipengaruhi oleh penyakit seperti TB dan pengobatannya.

O

Directly Observed Treatment (DOT): Pendekatan dalam pengobatan TB di mana pengawasan langsung dilakukan untuk memastikan pasien mengonsumsi obat dengan benar dan sesuai jadwal. Dalam konteks pemberdayaan keluarga, keluarga berperan sebagai pengawas dalam metode DOT untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan TB.

Pelayanan Keperawatan: suatu bentuk pelayanan profesional yang diberikan oleh perawat kepada individu, keluarga, dan komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual, dengan tujuan meningkatkan, mempertahankan, dan memulihkan kesehatan.

Pemberdayaan Keluarga: Upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas dan peran aktif keluarga dalam menjaga serta memulihkan kondisi kesehatan anggotanya melalui edukasi, pelatihan, dan keterlibatan langsung dalam perawatan.

Pencegahan Penularan TB: Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan penyebaran bakteri *Mycobacterium tuberculosis*, baik melalui ventilasi, etika batuk, maupun pengobatan yang tepat waktu.

Peran Keluarga: Kontribusi nyata dari anggota keluarga dalam mendampingi, memantau, serta memberikan dukungan psikososial dan praktis kepada pasien selama menjalani proses pengobatan.

Perilaku Kesehatan: Segala tindakan atau kebiasaan individu yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, seperti minum obat, menggunakan masker, menjaga kebersihan, dan mengakses layanan kesehatan.

M

Model community as partner: suatu pendekatan dalam keperawatan komunitas yang memandang komunitas sebagai mitra aktif dalam proses pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, bukan hanya sebagai objek intervensi.

Model Keluarga Berbasis Komunitas: pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan keluarga sebagai unit utama dalam upaya peningkatan derajat kesehatan, dengan melibatkan komunitas (masyarakat sekitar) sebagai mitra dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kesehatan.

R

Resistensi Obat: Kondisi ketika bakteri TB tidak lagi mempan terhadap satu atau lebih obat anti-TB, sering terjadi karena pengobatan tidak teratur atau tidak sesuai anjuran.

T

Tindak Lanjut: Pemantauan kondisi pasien secara berkala setelah diagnosis atau selama proses pengobatan untuk memastikan keberhasilan terapi dan mencegah kekambuhan.

Tingkat Kepatuhan: Derajat keteraturan dan konsistensi pasien dalam mengikuti jadwal dan aturan minum obat TB sesuai yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan.

Tuberkulosis (TB) Paru: Penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*, menyerang paru-paru, dan menyebar melalui udara saat pasien batuk atau bersin.

PROFIL PENULIS



Ns. Mila Triana Sari, M.Kep.

Lahir di Jambi, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang SI pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Andalas tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2009. Riwayat pekerjaan diawali sejak tahun 1995 di Akper Baiturrahim Jambi, tahun 2025 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim. Saat ini penulis bekerja di Universitas Baiturrahim Jambi, mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Metodologi Penelitian, Keperawatan Keluarga, Kewirausahaan, dan Pelayanan Prima. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu sebagai pengajar, penulis buku, melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, juga publikasi ilmiah pada jurnal nasional, internasional dan seminar Nasional dan Internasional baik sebagai peserta maupun pembicara, dan reviewer Jurnal.

Penulis dapat dihubungi melalui
e-mail: milatrianasari73@gmail.com

PROFIL PENULIS



Daryanto, SKP, M.Kep.

Lahir di Jambi, 20 Juli 1966, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh penulis yaitu jenjang SI pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tamat tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia, lulus tahun 2007. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Jambi, mengampu mata kuliah Keperawatan Jiwa, Psikologi Keperawatan, Komunikasi dalam Keperawatan dan Konsep Dasar

Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu sebagai pengajar, penulis buku, melakukan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, juga publikasi ilmiah pada jurnal nasional, internasional, dan seminar Nasional dan Internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: daryanto2766@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Hesty, S.Kep., M.Kes.

Lahir di Jambi, 29 Desember 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Program Sarjana STIKes Baiturrahim tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Kader Bangsa dan lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997. Saat ini penulis bekerja di Universitas Baiturrahim mengampu mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, Keperawatan Kesehatan Reproduksi,

Keperawatan Maternitas, Keperawatan Anak, Keperawatan Gerontik, Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut, Keperawatan Dasar Profesi, Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Pesarafan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hestywiki@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Buku ini mengkaji secara mendalam penerapan Model Family Centered Nursing dalam konteks pemberdayaan keluarga pasien Tuberkulosis Paru. Sebagai penyakit menular yang memerlukan kepatuhan pengobatan jangka panjang, TB Paru menimbulkan tantangan tersendiri baik bagi pasien maupun sistem kesehatan.

Kurangnya kepatuhan dalam menjalani terapi berisiko menimbulkan kegagalan pengobatan dan resistensi obat.

Melalui pendekatan keperawatan berbasis keluarga, buku ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif keluarga dalam proses perawatan, mulai dari pemberian dukungan emosional hingga pengawasan konsumsi obat harian. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menciptakan lingkungan pendukung yang mendorong pasien untuk tetap konsisten menjalani terapi sesuai anjuran medis.

Selain menjelaskan landasan teori dan konsep utama model keperawatan berbasis keluarga, buku ini juga memuat strategi implementasi di lapangan serta refleksi kritis terhadap tantangan yang mungkin dihadapi. Ditujukan bagi tenaga kesehatan, mahasiswa, dan praktisi keperawatan komunitas, karya ini hadir sebagai sumber referensi ilmiah dan praktis dalam pengelolaan TB Paru berbasis pendekatan kolaboratif antara tenaga kesehatan dan keluarga.

Buku ini mengkaji secara mendalam penerapan Model Family Centered Nursing dalam konteks pemberdayaan keluarga pasien Tuberkulosis Paru. Sebagai penyakit menular yang memerlukan kepatuhan pengobatan jangka panjang, TB Paru menimbulkan tantangan tersendiri baik bagi pasien maupun sistem kesehatan. Kurangnya kepatuhan dalam menjalani terapi berisiko menimbulkan kegagalan pengobatan dan resistensi obat. Melalui pendekatan keperawatan berbasis keluarga, buku ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif keluarga dalam proses perawatan, mulai dari pemberian dukungan emosional hingga pengawasan konsumsi obat harian. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menciptakan lingkungan pendukung yang mendorong pasien untuk tetap konsisten menjalani terapi sesuai anjuran medis. Selain menjelaskan landasan teori dan konsep utama model keperawatan berbasis keluarga, buku ini juga memuat strategi implementasi di lapangan serta refleksi kritis terhadap tantangan yang mungkin dihadapi. Ditujukan bagi tenaga kesehatan, mahasiswa, dan praktisi keperawatan komunitas, karya ini hadir sebagai sumber referensi ilmiah dan praktis dalam pengelolaan TB Paru berbasis pendekatan kolaboratif antara tenaga kesehatan dan keluarga.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-69965-0-6



9

786238

996506